

دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية

لإنشاء شركة لخدمات

الرعاية الصحية المنزلية

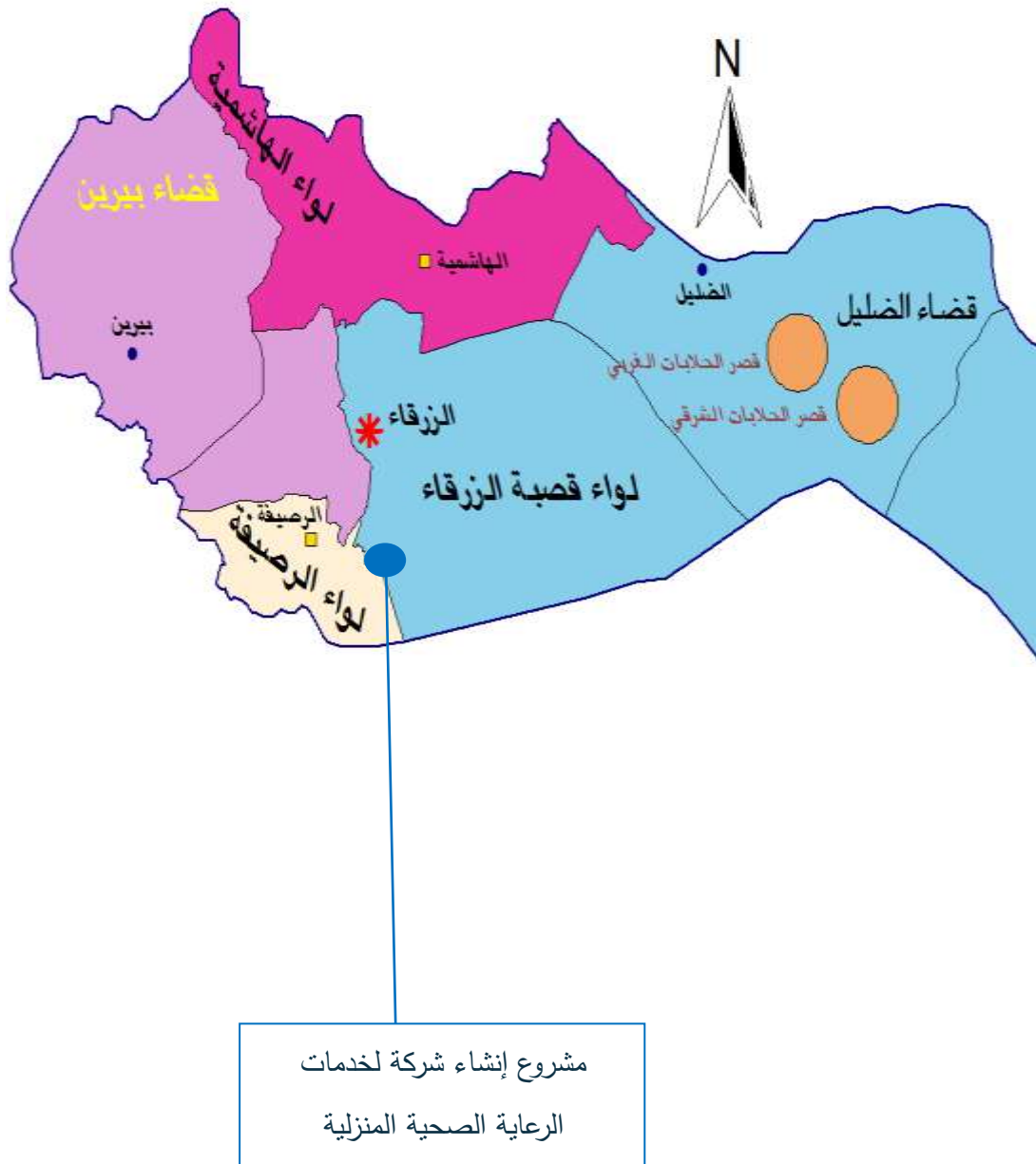
نيسان، 2017



جدول المحتويات

1.	المُلخَص التنفيذي.....	5
2.	البيئة الاقتصادية الكلية.....	8
2.1	لمحة عن المملكة الأردنية الهاشمية.....	8
2.2	السكان.....	9
2.3	المؤشرات الاقتصادية في المملكة.....	11
2.4	البيئة الاستثمارية في المملكة.....	14
2.5	البيئة الاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط.....	17
3.	دراسة السوق.....	18
3.1	وصف المشروع.....	18
3.2	وصف الخدمات المتوقعة.....	18
3.3	واقع القطاع الصحي في محافظة الزرقاء.....	19
3.4	تحليل السوق.....	21
3.5	تحليل الأسعار.....	39
3.6	الاستراتيجية التسويقية.....	40
3.5	حجم الطلب المتوقع.....	44
4.	الدراسة الفنية للمشروع.....	46
4.1	الطاقة التصميمية للمشروع.....	46
4.2	الموارد المادية المطلوبة.....	47
4.3	الموارد البشرية المطلوبة.....	49
4.4	الاشتراطات الخاصة.....	53
4.5	التراخيص المطلوبة.....	55
4.6	الجدول الزمني للمشروع.....	56
5.	الدراسة المالية للمشروع.....	57
5.1	الافتراضات المالية.....	57
5.2	تكاليف الاستثمار.....	58
5.3	التمويل.....	58
5.4	الإيرادات.....	58
5.5	التكاليف المتوقعة.....	62
5.6	القوائم المالية المتوقعة.....	63

- 5.7 التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي 66
6. دراسة المخاطر وتحليل الحساسية 70
- 6.1 دراسة المخاطر 70
- 6.2 تحليل الحساسية 73



1. الملخص التنفيذي

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية المبدئية لمشروع إنشاء شركة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية في محافظة الزرقاء تقدم خدمات التمريض المنزلي لسكان المحافظة والمحافظات المجاورة الذين يرغبون أو تستدعي ظروفهم المرضية أو الشخصية الحصول على الخدمات التمريضية اللازمة لهم في منازلهم والذين يعانون من حالات مرضية مزمنة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن تتطلب حالاتهم العناية الخاصة والمتابعة إلى أن يتم الإنتهاء من علاجهم.

الجدول 1: المؤشرات الأولية للمشروع

اسم المشروع	إنشاء شركة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية (تمريض منزلي وعلاج حتمي داخل وخارج المركز)
القطاع	قطاع الصحة
المحافظة	الزرقاء
المنطقة	قصة الزرقاء، الرصيفة
المنتجات/الخدمات	- تقديم خدمات التمريض المرافق للمريض في المنزل على مدار الساعة وذلك للحالات المستعصية والمزمنة مثل حالات الغيبوبة الدماغية وكبار السن، حيث يتم تأمين المريض بممرض/ممرضة مرافقة على ورديتين (ليلي/نهاري) وذلك للقيام بتأدية المهام والخدمات التالية للمريض: - توفير الأجهزة الطبية للحالات المستعصية مثل السرير الطبي، جهاز التنفس، جهاز سحب البلغم suction، جهاز قياس الضغط، جهاز قياس السكر، الشراشف الخاصة، أكياس البول، المحاليل الوريدية، الكانيولا، المستلزمات الطبية مثل القطن والحقن وغيرها. - القيام بمتابعة المرضى في المنزل وقياس مستويات الضغط والسكر وتركيب الكانيولا لأخذ عينات الدم، وأخذ عينات البول لفحصها بين الحين والآخر...الخ - تنظيف المريض والمساعدة بتغسيله - العمل على راحة المريض في المنزل ومراقبة حالته الصحية - إعطاء المريض أدويته بانتظام وبحسب تعليمات الطبيب المشرف على الحالة - إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، والعناية بالجروح، والرعاية بعد القسرة البولية والعناية بالتقرحات الجلدية - العناية بفتحات البراز خارج جدار البطن - العلاج بالحقن الوريدية في المنزل - رعاية مرضى السكري

• التنسيق مع خدمات سيارات الإسعاف • خدمات الرعاية غير الطبية والتي تقدمها مجموعة من مساعدات التمريض ومقدمي الخدمة وذلك من أجل مساعدة كبار السن، والمعاقين، والمرضى على الاستشفاء والنقاهة في بيوتهم الخاصة ومنها المساعدة في الاستحمام والتزين، ومراقبة الحمية وعادات الأكل، والمساعدة في الوجبات الغذائية والمشى والتنقل، والتذكير بمواعيد الدواء والتمارين الرياضية لتحسين حركة المفاصل، ومراقبة المرضى لزيارة الأطباء، والمصاحبة وتبادل الحديث. • العلاج الحكي (العلاج الطبيعي والوظيفي) ويشمل: - تأهيل أمراض وإصابات النخاع الشوكي والعمود الفقري - تأهيل أمراض الجهاز العضلي - الحركي - تأهيل أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام - تأهيل الإصابات الرياضية والشد العضلي	
يقوم المشروع على اجتذاب المرضى والمرضات المنزليين والمعالجين الطبيعيين المؤهلين ويعمل المشروع على تطوير هذه الخدمات وجعلها آمنة وميسرة للراغبين بالاستفادة منها دون مشاكل عن طريق تعيينهم بعقود منتظمة، حيث تعمل الشركة على تعيينهم وتدريبهم وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات.	وصف المشروع
تبلغ كلفة المشروع الاستثمارية حوالي 321 ألف دينار	التكلفة الاستثمارية
يبلغ متوسط العائد على الاستثمار خلال العشر سنوات حوالي 10.8%	متوسط معدل العائد على الاستثمار
يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع حوالي 19.7%	معدل العائد الداخلي
يبلغ متوسط القيمة المضافة على المشروع خلال عشر سنوات حوالي 319 ألف دينار	متوسط القيمة المضافة على المشروع
يشير تحليل الحساسية إلى انخفاض درجة مخاطرة المشروع للتغير في زيادة الاستثمار 10%، أو زيادة التكاليف التشغيلية 10%، وارتفاع درجة المخاطرة للتغير في تخفيض الإيرادات 10%.	درجة المخاطرة
• تقديم خدمة التمريض والعلاج الطبيعي المنزلي بشكل منظم • إيجاد بيئة آمنة للعمل والتعاقد مع المنازل • خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد • تشغيل المزيد من المرضى والمرضات وأخصائيي التأهيل والعلاج الطبيعي المتعطلين و/أو المتقاعدين • عدم وجود مراكز تأهيل مشابهة في المحافظة، إنما يوجد بعض الأشخاص الذين يؤدون هذه الخدمة في المنازل بعد انتهاء دوامهم في المستشفيات • زيادة الطلب على مراكز الخدمات المشابهة في محافظات أخرى	مبررات المشروع

• زيادة نسبة التأمين الصحي الخاص • لا توجد خدمات متكاملة في علاج الحالات المزمنة تجمع ما بين التمريض المنزلي والعلاج الحكي (الطبيعي والوظيفي) • يتم تقديم هذه الخدمات حالياً داخل المحافظة بشكل فردي وغير منظم أو من خلال بعض المؤسسات من عمان • توجد مراكز للعلاج الحكي فقط ولا زالت الحاجة ملحة لوجود مراكز أخرى	
• وزارة الصحة • البلدية المعنية	الجهات الشريكة

2. البيئة الاقتصادية الكلية

2.1 لمحة عن المملكة الأردنية الهاشمية

تعد المملكة الأردنية الهاشمية بلداً محاطاً باليابسة بصورة شبه كلية باستثناء منطقة ميناء العقبة التي تقع في أقصى الجنوب حيث تعد تلك المنطقة منفذ الأردن الوحيد على البحر. ويحد المملكة من الغرب فلسطين والبحر الأبيض المتوسط كما وتحده السعودية من الجنوب والشرق، والعراق من الشمال الشرقي وسوريا من الشمال.

الشكل 1: خارطة المملكة الأردنية الهاشمية



هناك ثلاث مناطق مناخية تميز الأردن من الغرب إلى الشرق وتشمل هذه المناطق وادي الأردن الذي يقع أغلبه تحت مستوى سطح البحر ويعتبر شبه استوائي، والمناطق المرتفعة إلى الشرق من وادي الأردن، ويتراوح ارتفاعها ما بين 100 - 1500 متراً فوق سطح البحر وتعتبر من المناطق التي يسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناطق الصحراوية الممتدة إلى الشرق من المرتفعات.

تبلغ المساحة الكلية للمملكة حوالي 89.3 ألف كيلو متر مربع، وتسود الظروف شبه الصحراوية في ما يزيد على 80% من هذه المساحة التي تتواجد بها بعض الأراضي الرطبة كحوض الأزرق.

تنقسم المملكة إدارياً إلى إثنتي عشرة محافظة موزعة على ثلاثة أقاليم وهي: إقليم الشمال (ويضم محافظات إربد، المفرق، جرش وعجلون)، إقليم الوسط (ويضم محافظات العاصمة، الزرقاء، البلقاء، مادبا) وإقليم الجنوب (ويضم محافظات الكرك، الطفيلية، معان، العقبة)، أما المدن الرئيسية فهي عمان (العاصمة) والزرقاء وإربد.

2.2 السكان

استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، فقد بلغ عدد السكان في المملكة حوالي 9.5 مليون نسمة وبكثافة سكانية 107.3 نسمة/ كم²، حيث تربعت محافظة العاصمة على المحافظات الأخرى بعدد السكان والبالغ حوالي 4 مليون نسمة وبكثافة سكانية 538.8 نسمة/ كم² ويعود ذلك بشكل رئيسي لكونها المحافظة الأكثر جذباً للأردنيين وللقادمين إلى المملكة من الجنسيات الأخرى، وتلتها محافظة إربد بعدد سكان 1.8 مليون نسمة ومن ثم محافظة الزرقاء بعدد سكان 1.4 مليون نسمة. وتعتبر محافظة الطفيلة هي الأقل من حيث عدد السكان فبلغ عدد السكان فيها حوالي 96 ألف نسمة.

الجدول 2: عدد السكان والكثافة السكانية في المملكة لعام 2015

المحافظة	عدد السكان (نسمة)	المساحة (كم ²)	الكثافة السكانية (نسمة/ كم ²)
إقليم الوسط			
العاصمة	4007526	7,579	528.8
الزرقاء	1364878	4761	286.7
البلقاء	491709	1120	439.0
مادبا	189192	940	201.3
إقليم الشمال			
إربد	1770158	1572	1126.1
المفرق	549948	26551	20.7
جرش	237059	410	578.2
عجلون	176080	420	419.2
إقليم الجنوب			
الكرك	316629	3495	90.6
الطفيلة	96291	2209	43.6
معان	144082	32832	4.4
العقبة	188160	6905	27.2
مجموع المملكة	9531712	88793.5	107.3

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015

ومن جهة أخرى، فقد بلغ معدل النمو السكاني حوالي 3% في عام 2010 وازداد ليصل إلى 9% خلال العامين 2013 و2014 ومن ثم انخفض بشكل قليل خلال عام 2015 ليصل نحو 8% وذلك بحسب المسوح السكانية لدائرة الإحصاءات العامة، ويعزى السبب في ارتفاع معدلات النمو إلى توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة مما ترتب عليه حدوث تراجع ملحوظ في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونسبة 5.4% ليصل إلى 1,197.4 دينار وذلك استناداً إلى البنك المركزي الأردني.

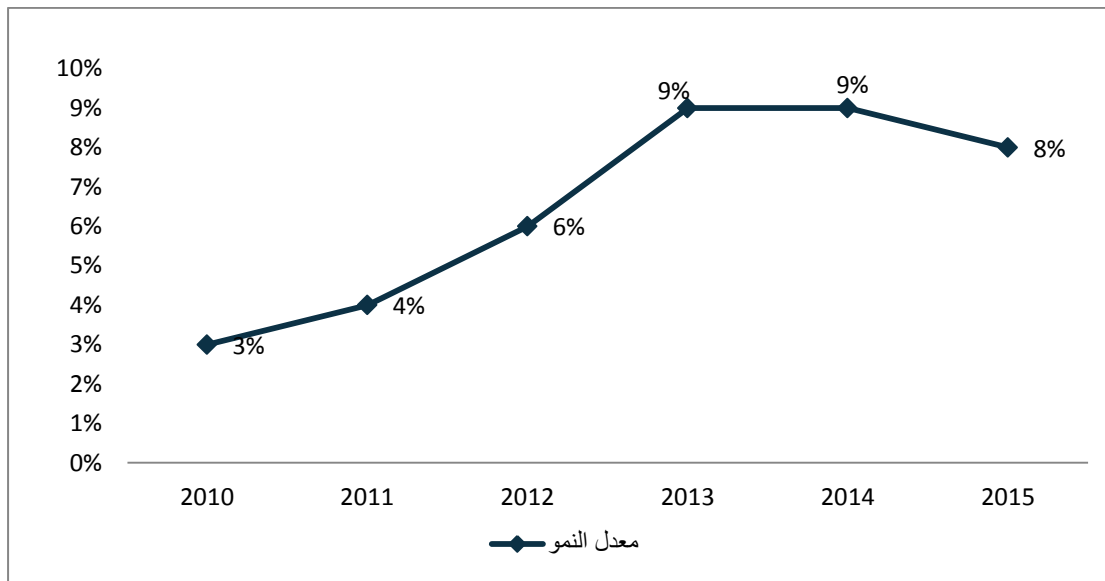
كما شهد معدل البطالة بين الأردنيين ارتفاعاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 13%، وذلك نظراً لما يعانيه سوق العمل من اختلالات هيكلية واستحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجر على عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد وذلك بحسب البنك المركزي الأردني.

الجدول 3: عدد السكان والنمو السكاني في المملكة

2015	2014	2013	2012	2011	2010	
9531.7	8804.0	8114.0	7427.0	6993.0	6698.0	عدد السكان
%8	%9	%9	%6	%4	%3	معدل النمو

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

الشكل 2: معدل النمو السكاني في المملكة



2.3 المؤشرات الاقتصادية في المملكة¹

ما زال الوضع الذي تعاني منه دول المنطقة من عدم الاستقرار والإغلاق الكلي أو الجزئي للحدود ومنها حدود لأسواق هامة لمنتجات المملكة إلى تراجع في أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 2.4% في عام 2015، مقابل 3.1% خلال عام 2014. وقد جاء النمو المتحقق خلال عام 2015 مدفوعاً بنمو معظم القطاعات الاقتصادية. لاسيما خدمات المال والتأمين والعقارات، والنقل والتخزين والاتصالات، والصناعة الاستخراجية، والصناعة التحويلية، والزراعة، إذ ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بمقدار 1.8 نقطة مئوية (أو ما نسبته 75%) من معدل النمو المتحقق خلال عام 2015، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

علاوة على ذلك سجل المستوى العام للأسعار انخفاضاً في أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية، وبالتالي شهد المستوى العام للأسعار، مقاساً بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انكماشاً بنسبة 0.9% خلال عام 2015 بالمقارنة مع تضخم نسبته 2.9% في عام 2014.

كما سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات ارتفاعاً بمقدار 1.2 نقطة مئوية مسجلاً 3.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.3% خلال العام الماضي إضافة إلى تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بلغ 8.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% خلال عام 2014. وفيما يتعلق بالمديونية، بشقيها الداخلي والخارجي، فقد بلغ صافي الدين العام 22,847.5 مليون دينار (85.8% من الناتج) في نهاية عام 2015، وبارتفاع مقداره 5.0 نقاط مئوية من الناتج. أما إجمالي الدين العام فبلغ 24,876.5 مليون دينار (93.4% من الناتج). وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، هذا فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015. ومن الجدير بالذكر أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سجلت ما قيمته 6.7 مليار دينار في نهاية عام 2015.

أما على الصعيد النقدي والمصرفي فقد شهدت معظم المؤشرات النقدية تطوراً إيجابياً في أدائها في عام 2015، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولار ليعكس تحسن الطلب على الدينار الأردني كعملة ادخارية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى. وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة، سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً نسبته 9.5% ليصل إلى 21,103.5 مليون دينار في نهاية عام 2015. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفاعاً نسبته 7.7% في نهاية عام 2015 ليصل إلى 32,598.5 مليون دينار. وقد جاء التحسن في الودائع نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 2,001.4 مليون دينار (8.3%) وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار (5.4%).

¹ المصدر: البنك المركزي الأردني

بالإضافة الى ذلك فقد سجلت العديد من مؤشرات القطاع الخارجي تراجعاً في أداؤها خلال عام 2015 جراء تعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة والإغلاق شبه التام للحدود مع كل من سوريا والعراق، إلا أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في انخفاض فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة بشكل ملموس، حيث انخفضت بنسبة 40.6%، والتي أسهمت بدورها بتراجع إجمالي المستوردات وعجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% و 14.0%، على التوالي.

في حين ارتفع عجز الحساب الجاري بعد المساعدات ليصل إلى 2,365.6 مليون دينار (8.9% من الناتج) خلال عام 2015، بالمقارنة مع عجز بلغ 1,851.7 مليون دينار (7.3% من الناتج) خلال عام 2014. ويعود هذا التراجع بشكل رئيس إلى تراجع الصادرات الكلية بنسبة 6.6%، وتراجع الفائض في حساب الخدمات بنسبة 27.7%، حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 7.1%، كما تراجع الفائض في حساب التحويلات الجارية نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1,593.7 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل 909.0 مليون دينار خلال عام 2014، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التزامات المملكة نحو العالم الخارجي، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل مقداره 904.4 مليون دينار، كما سجلت استثمارات الحافظة تدفقاً للداخل بلغ 918.4 مليون دينار، وذلك بسبب قيام المملكة بإصدار ما قيمته 2.0 مليار دولار سندات اليوروبوندر السيادية في الأسواق العالمية، كما ارتفعت مسحوبات القروض للبنك المركزي نتيجة لاستخدام تسهيلات صندوق النقد الدولي والعربي بمقدار 543.3 مليون دينار.

هذا وقد أظهر وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2015 ارتفاعاً في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014، نتيجة ارتفاع رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية لكافة القطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة لتبلغ 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار خلال عام 2015، على التوالي.

الجدول 4: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 2011-2015 بالمليون دينار

2015	2014	2013	2012	2011	
9,532	8,804	8,114	7,427	6,993	عدد السكان (بالمليون نسمة)
13.0	11.9	12.6	12.2	12.9	معدل البطالة
الانتاج والأسعار					
26,289.6	25,141.2	23,611.2	21,690.0	20,288.8	الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
26,637.4	25,437.1	23,851.6	21,965.5	20,476.6	الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
2.4	3.1	2.8	2.7	2.6	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة (%)
30,234.7	30,302.1	28,424.5	24,774.9	23,743.5	إجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية
-2.4	3.1	8.6	-0.2	4.7	معدل النمو في إجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الثابتة (%)
-0.9	2.9	4.8	4.5	4.2	التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (%)
2.3	3.4	5.6	4.5	6.4	التغير في مخفض الناتج المحلي الإجمالي (%)

2015	2014	2013	2012	2011	
التقود والبنوك					
1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي (دولار/دينار)
31,605.5	29,240.4	27,363.4	24,945.2	24,118.9	عرض النقد (ع2)
8,137.3	7,932.3	6,923.4	6,665.5	9,370.1	صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي
23,468.2	21,308.1	20,440.0	18,279.7	14,748.8	صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي
11,386.4	10,473.9	10,494.8	9,461.3	6,701.4	صافي الديون على الحكومة
18,704.5	17,852.8	17,222.5	15,953.6	14,925.0	الديون على القطاع الخاص (مقيم)
-6,622.7	-7,018.5	-7,277.3	-7,135.2	-6,877.6	صافي العوامل الأخرى ⁽¹⁾
26,014.5	24,013.1	21,003.0	17,711.1	19,119.1	الودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة
6,584.0	6,247.9	6,590.2	7,258.6	5,258.8	الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك المرخصة
3.75	4.25	4.50	5.00	4.50	سعر إعادة الخصم (%)
-	-	-	3.788	3.232	سعر فائدة اذونات الخزينة 6 أشهر (%)
المالية العامة					
6,796.4	7,267.6	5,758.9	5,054.2	5,413.9	إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية
25.5	28.6	24.1	23.0	26.4	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
7,722.9	7,851.1	7,077.1	6,878.2	6,796	إجمالي الإنفاق
29.0	30.9	29.7	31.3	33.2	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
-926.5	-583.5	-1,318.2	-1,824.0	-1,382.7	العجز / الوفر الكلي (على أساس الاستحقاق)
-3.5	-2.3	-5.5	-8.3	-6.8	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
13,457.0	12,525.0	11,863.0	11,648.0	8,915.0	صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي
50.5	49.2	49.7	53.0	43.5	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
9,390.5	8,030.1	7,234.5	4,932.4	4,486.8	الرصيد القائم للدين العام الخارجي ⁽²⁾
35.3	31.6	30.3	22.5	21.9	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات					
-2,365.6	-1,851.7	-2,487.7	-3,344.9	-2,098.8	الحساب الجاري
-8.9	-7.3	-10.4	-15.2	-10.2	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
-7,249.3	-8,495.6	-8,270.1	-7,486.6	-6,261.7	الميزان التجاري (العجز -)
-27.2	-33.4	-34.7	-34.1	-30.6	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
5,558.3	5,953.6	5,617.9	5,599.5	5,684.5	الصادرات السلعية (فوب)
12,807.6	14,449.2	13,888.0	13,086.1	11,946.2	المستوردات السلعية (فوب) ⁽³⁾
1,286.4	1,778.9	1,209.5	1,332.3	896.0	ميزان الخدمات (صافي)
-347.8	-295.9	-240.4	-275.5	-187.8	حساب الدخل (صافي)
3,945.1	5,160.9	4,813.3	3,084.9	3,454.7	التحويلات الجارية (صافي)
1,593.7	908.9	1,811.1	3,808.9	2,298.9	الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)، منه:
905.1	1,426.7	1,281.2	1,074.3	1,055.0	الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن (صافي)

المصدر: النشرة الإحصائية الشهرية-البنك المركزي الأردني.

(1): يشمل على الديون على المؤسسات العامة والديون على المؤسسات المالية ويند صافي العوامل الأخرى كما يظهر في جدول المسح النقدي.

(2): يمثل هذا الرصيد إجمالي القروض المسحوبة مطروحا منه إجمالي التسديدات.

(3): لا تشمل على مستوردات الجهات غير المقيمة.

2.4 البيئة الاستثمارية في المملكة

قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

يعتبر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز للاستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الإستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم مجموعة من الحوافز والمزايا داخل وخارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، كما ضمن القانون مجموعة من الاحكام العامة مثل ضمانات الاستثمار الاجنبي (إدخال وإخراج رأس المال، ادارة الاستثمار، التحويلات)، عدم جواز نزع ملكية الاستثمار. تسوية نزاعات الاستثمار، اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى.

وفيما يلي أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الإستثمار للمشاريع الإستثمارية:

❖ الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

- إعفاء مدخلات انتاج القطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية
- رد الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي والحرفي خلال (30) يوم
- إعفاء مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفر) على الضريبة العامة على المبيعات
- إعفاء الموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفر) على الضريبة العامة على المبيعات
- رد للضريبة العامة على المبيعات على الخدمات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي خلال (30) يوم
- تتمتع السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تالياً بالإعفاء من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر):
- الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويج السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، الإنتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية، النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية

❖ الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة

- 5% ضريبة دخل على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المنطة التنموية
- 5% ضريبة دخل على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي في القطاع الصناعي
- الإعفاءات الضريبية الممنوحة في المملكة على الصادرات من السلع والخدمات

- تخفيض على ضريبة المبيعات بنسبة (الصفر) على السلع والخدمات التي تستخدمها المؤسسة لغايات ممارسة نشاطها داخل المنطقة التنموية
- 7% ضريبة مبيعات على خدمات محددة مقدمة من شركة مسجلة في المنطقة عند استهلاكها داخل المنطقة.
- إعفاءات من الرسوم الجمركية باستثناء عدد محدد من السلع

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016

- تم إقرار نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في من خلال تخفيض ضريبة الدخل خارج المناطق التنموية في المناطق الأقل نمواً في المملكة والذي تم فيه حديد المناطق التي تتمتع بهذا التخفيض وأسس ومعايير ومدته إضافة إلى تحديد الأنشطة المستثناة من هذا التخفيض
- وبموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من النظام تم تصنيف المناطق الأقل نمواً في المملكة والتي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل إلى أربع فئات تتمتع كل فئة منها بنسبة تخفيض على ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة لمدة (عشرين سنة):
 - الفئة (أ): وتشمل لواء الأغوار الشمالية ولواء ديرعلا ولواء الشونة الجنوبية ولواء الأغوار الجنوبية ولواء الرويشد ولواء البادية الشمالية ولواء البادية الشمالية الغربية وقضاء الأزرق ولواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة ولواء الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر ومحافظة العقبة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 100 %
 - الفئة (ب): وتشمل محافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظة الكرك ومحافظة عجلون، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 80%
 - الفئة (ج): وتشمل محافظة جرش ومحافظة المفرق ومحافظة اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 60%
 - الفئة (د): وتشمل محافظة مادبا ومحافظة البلقاء ومحافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى ومحافظة الزرقاء باستثناء حدود بلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيفة، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 40%

الإتفاقيات التجارية والحرّة

- من أهم هذه الإتفاقيات:
- انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، والذي أدى إلى فتح أسواق (150) دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ووفر فرص جديدة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة
- مجموعة الإتفاقيات التجارية الإقليمية مثل إتفاق الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي، وإتفاقية أغادير، وإتفاقية التجارة العربية الحرة، وإتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، واعتماد نظام قواعد المنشأ

الأورومتوسطي بما فيه قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/7/19 ولغاية 2026/12/31

- مجموعة من الإتفاقيات التجارية الثنائية مع العديد من الدول مثل إتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، و المناطق الصناعية المؤهلة، وإتفاقية الأردن وسنغافورة للتجارة الحرة، وإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإتفاقية للتجارة الحرة مع كندا، وغيرها من الإتفاقيات
- توقيع أكثر من 35 إتفاقية مع الدول العربية والأجنبية لمنع الإزدواج الضريبي بين الأردن وتلك الدول حماية لحقوق المستثمرين
- توقيع "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية" عام 2000 مع 11 دولة عربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في الدول العربية وبالتالي دفع وتحفيز أنشطة الاستثمارات فيها من خلال تقديم التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات العربية

تقرير التنمية البشرية لعام 2015

ترجع ترتيب المملكة في تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب 3 مراكز واحتل المرتبة 80 بينما كان يحتل المرتبة 77 في تقرير التنمية البشرية لعام 2014، علماً بأن درجة المملكة على المؤشر قد تحسنت بشكل طفيف جداً.

تقرير التنافسية العالمي

تحسن ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2017/2016 ليقفز نقطة واحدة، وليحقق المرتبة 63 من 138 دولة في تقرير التنافسية العالمي 2017/2016، بدلاً من المرتبة 64 من 140 دولة في تقرير العام الماضي (2016/2015)، وهو تحسن غير ملموس خصوصاً بسبب انخفاض عدد الدول المشاركة في التقرير في هذا العام. كما احتلت المملكة المركز السادس عربياً بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والتي حلت في المراتب: 16 و 18، و 29، و 34، و 39، على التوالي.

تقرير ممارسة الأعمال

أما في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي فلا زالت المملكة تروح مكانها باحتلالها المرتبة 118 في تقرير العام 2017 متقدماً بمرتبة واحدة عن تقرير العام 2016 والذي احتلت فيه المرتبة 119، وسط تباين في أداء المؤشرات الفرعية المختلفة. وقد احتلت المملكة المركز التاسع عربياً في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً إذ جاءت في المرتبة 26، تليها البحرين 63، ثم سلطنة عمان 66.

2.5 البيئة الاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط

يشير تحليل المخاطر الذي تقوم به BMI إلى إن مخاطر الأردن السياسية والاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط هي أفضل من المتوسط العام للعالم والشرق الأوسط، كما جاءت مخاطر الدولة والمخاطر التشغيلية ضمن مستويات مقبولة، كما تشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة في المؤشرات الاقتصادية والتجارة الخارجية باستثناء الزيادة المستمرة في المديونية الداخلية والخارجية.

الجدول 5: تقييم درجة المخاطر قصيرة وطويلة الأجل

مخاطر الدولة	المخاطر التشغيلية	المدى الطويل		المدى القصير		
		اقتصادي	سياسي	اقتصادي	سياسي	
55.4	58.7	46.2	66.6	39.2	63.1	الأردن
56.1	55.9	56.9	58.4	49.4	60.2	تركيا
47.5	42.9	48.7	52.4	45.0	53.3	مصر
49.5	44.2	53.5	55.4	54.0	45.8	لبنان
34.3	32.5	36.5	32.2	38.1	33.1	الضفة الغربية وغزة
26.1	29.3	23.6	22.4	24.4	22.9	سوريا
48.3	46.6	48.7	51.2	46.9	49.4	متوسط المنطقة
54.6	49.8	51.9	61.3	50.7	64.1	متوسط العالم

المصدر: الاقتصاد ومخاطر الدولة، IHS، 2016/9/15

الجدول 6: أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	المؤشر
3.1	3.2	2.8	2.7	2.6	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
50.9	47.8	44.8	42.1	39.6	الناتج المحلي الإجمالي (بالبليون دولار أمريكي)
11.0	10.7	10.4	10.1	9.8	عدد السكان (بالمليون)
3.2	4.0	3.3	1.8	0.7-	الرقم القياسي لأسعار المستهلك (% تغير)
9.6	8.8	8.2	7.6	7.3	الصادرات (بالبليون دولار أمريكي)
22.8	21.3	20.1	19.2	18.3	الواردات (بالبليون دولار أمريكي)
1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (بالبليون دولار أمريكي)
3.3	3.4	3.6	3.7	3.7	الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (% إجمالي الناتج المحلي)
17.7	16.8	15.7	14.9	13.9	احتياطي النقد الأجنبي (بالبليون دولار أمريكي)
36.0	33.7	30.7	27.8	24.4	مجموع الدين الخارجي (بالبليون دولار أمريكي)
70.6	70.4	68.6	66.0	61.6	مجموع الدين الخارجي (% إجمالي الناتج المحلي)
147.8	147.5	143.6	138.3	127.3	مجموع الدين الخارجي (% من كسب العملات الأجنبية)

المصدر: الاقتصاد ومخاطر الدولة، IHS، 2016/9/15

3. دراسة السوق

3.1 وصف المشروع

يقوم المشروع على اجتذاب الممرضين والممرضات المنزليين والمعالجين الطبيعيين المؤهلين ويعمل المشروع على تطوير هذه الخدمات وجعلها آمنة وميسرة للراغبين بالاستفادة منها دون مشاكل عن طريق تعيينهم بعقود منتظمة، حيث تعمل الشركة على تعيينهم وتدريبهم وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات. تكمن أهمية المشروع في تقصير مدة إقامة المرضى في المستشفى وتقليل التكلفة المادية سواءً على المرضى أو على شركات التأمين وضمان استمرارية الرعاية والعلاج المناسب في بيت المريض واستمرارية تنقيف المريض بما يتناسب مع احتياجاته. ويشتمل المشروع على ما يلي:

- إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية والعناية بالجروح والعناية بالتقرحات الجلدية ورعاية مرضى السكري والأمومة
- خدمات الرعاية غير الطبية المقدمة من قبل طاقم التمريض ومقدمي الخدمة وذلك من أجل مساعدة كبار السن والمعاقين والمرضى على الاستشفاء والنفاضة في بيوتهم الخاصة
- المتابعة التمريضية وتشمل متابعة الحالة التي تتطلب متابعة طويلة الأجل للأمراض المزمنة
- متابعة الحالة بشكل عام بعد المستشفى
- العلاج الحكي (الطبيعي والوظيفي)

3.2 وصف الخدمات المتوقعة

تشمل خدمات المشروع ما يلي:

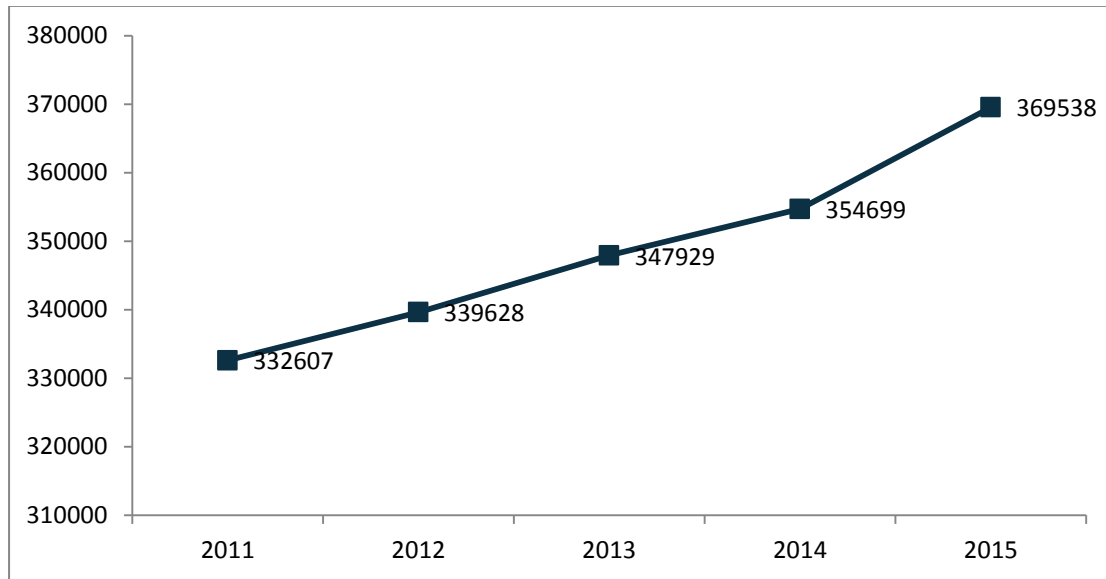
- تقديم خدمات التمريض المرافق للمريض في المنزل على مدار الساعة وذلك للحالات المستعصية والمزمنة مثل حالات الغيبوبة الدماغية وكبار السن، حيث يتم تأمين المريض بمرض/ ممرضة للمرافقة على وريتين (يلي/ نهاري) وذلك للقيام بتأدية المهام والخدمات التالية للمريض:
- توفير الأجهزة الطبية للحالات المستعصية مثل السرير الطبي، جهاز التنفس، جهاز سحب البلغم suction، جهاز قياس الضغط، جهاز قياس السكر، الشراشف الخاصة، أكياس البول، المحاليل الوريدية، الكانيولا، المستلزمات الطبية مثل القطن والحقن وغيرها.
- القيام بمتابعة المرضى في المنزل وقياس الضغط والسكر وتركيب الكانيولا لأخذ عينات الدم، وأخذ عينات البول لفحصها بين الحين والآخر... الخ
- تنظيف المريض والمساعدة بتغسيله
- العمل على راحة المريض في المنزل ومراقبة حالته الصحية
- إعطاء المريض أدويته بانتظام وبحسب تعليمات الطبيب المشرف على الحالة
- إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، والعناية بالجروح، والرعاية بعد القسرة البولية والعناية بالتقرحات الجلدية
- العناية بفتحات البراز خارج جدار البطن
- العلاج بالحقن الوريدية في المنزل

- رعاية مرضى السكري
- العلاج النفسي، والعلاج التنفسي، والتحويل إلى المستشفيات عند الضرورة
- التنسيق مع خدمات سيارات الإسعاف
- خدمات الرعاية غير الطبية والتي تقدمها مجموعة من مساعدات التمريض ومقدمي الخدمة وذلك من أجل مساعدة كبار السن، والمعاقين، والمرضى على الاستشفاء والنفاضة في بيوتهم الخاصة ومنها المساعدة في الاستحمام والتزين، ومراقبة الحمية وعادات الأكل، والمساعدة في الوجبات الغذائية والمشى والتنقل، والتذكير بمواعيد الدواء والتمارين الرياضية لتحسين حركة المفاصل، ومراقبة المرضى لزيارة الأطباء، والمصاحبة وتبادل الحديث.
- العلاج الحكمي (العلاج الطبيعي والوظيفي) ويشمل:
 - تأهيل أمراض وإصابات النخاع الشوكي والعمود الفقري
 - تأهيل أمراض الجهاز العضلي - الحركي
 - تأهيل أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام
 - تأهيل الإصابات الرياضية والشد العضلي

3.3 واقع القطاع الصحي

بلغ عدد مستشفيات المملكة الكلي في عام 2015 بناءً على تقرير وزارة الصحة 102 مستشفى، منها 31 مستشفى تابع لوزارة الصحة و12 مستشفى للخدمات الطبية الملكية بالإضافة إلى 59 مستشفى من القطاع الخاص، كما بلغ عدد الأسرة لكل 10000 نسمة من السكان 13 سريرًا، ويبين الشكل التالي تطور عدد الإدخالات في مستشفيات وزارة الصحة في المملكة خلال الأعوام 2011 – 2015.

الشكل 3: عدد إدخالات مستشفيات وزارة الصحة خلال الأعوام (2011 – 2015).



المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي 2015

وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، فقد بلغ عدد المراكز الصحية في المملكة 675 مركزاً صحياً في العام 2015، منها 99 مركزاً شاملاً و 378 مركزاً أولياً و 198 مركزاً ثانوياً.

وعلى مستوى محافظة الزرقاء، فإن القطاع الصحي يعتبر من القطاعات التي لا زالت مؤشراتنا منخفضة مقارنة مع نسبها على مستوى المملكة حيث يلاحظ أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة الزرقاء قد بلغ 109 مركز تمثل ما نسبته 7% من أعدادها على مستوى المملكة، كما يبلغ معدل عدد السكان لكل مركز صحي 12522 وهو أعلى بكثير من معدله على مستوى المملكة والذي يبلغ 6202.

كما هو الحال في مؤشرات قطاع الخدمات الصحية الأولية فإن قطاع المستشفيات يعاني من مشاكل مشابهة تتعلق بالضغط على الخدمات ونقص الكوادر حيث يوجد في محافظة الزرقاء 8 مستشفيات تحتوي على 1315 سريراً، منها 5 مستشفيات للقطاع الخاص تحتوي على 315 سريراً و 3 مستشفيات للقطاع العام تحتوي على 1000 سرير.

حيث يلاحظ أن عدد الأسرة لكل 10000 نسمة في محافظة الزرقاء تبلغ 10 وهي أقل من معدلها على مستوى المملكة والذي يبلغ 13. بالإضافة إلى ذلك يقل هذا المعدل بشكل كبير خاصة في أسرة مستشفيات القطاع الخاص والتي تصل إلى حوالي نصف معدلها على مستوى المملكة، ويمكن أن نعزو ذلك إما إلى ضعف القدرة الشرائية لدى السكان أو إلى ضعف جودة الخدمات الصحية وشموليتها للتخصصات المطلوبة في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى قرب المحافظة من عمان وحصول السكان على خدمات طبية متخصصة من مقدمي الخدمة في العاصمة.

كما يلاحظ أن معدل الموظفين إلى عدد الأسرة في مستشفى الزرقاء الحكومي هو تقريباً الأقل على مستوى المملكة حيث تبلغ نسبته 0.5 في حين يبلغ ذلك المعدل على مستوى المملكة 3.1.

القوى العاملة في القطاع

يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي في محافظة الزرقاء حوالي 5,872 موظفاً وقد شكل ذلك ما نسبته 3.2% من إجمالي العاملين في محافظة الزرقاء و 8.4% على مستوى المملكة، حيث يلاحظ أن عدد العاملين في القطاع الصحي في محافظة الزرقاء أقل من معدل العمالة في القطاع الصحي في المملكة والذي يعكس الحاجة إلى الاهتمام بالقطاع ورفع الكوادر الصحية المناسبة.

الجدول 7: عدد العاملين في القطاع الصحي

القطاع	محافظة الزرقاء	المملكة	نسبة المحافظة إلى المملكة
عدد العاملين في القطاع الصحي	5,872	69,902	8.4%
عدد العاملين الكلي	183,507	1,398,029	13.13%
نسبة العاملين في القطاع الصحي	3.2%	5.0%	

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، العمالة والبطالة، احتساب فرق العمل

3.4 تحليل السوق

تفتقر محافظة الزرقاء إلى وجود شركات متكاملة للرعاية الصحية المنزلية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب المتابعة والعناية الخاصة بعد الحوادث والكسور والحروق والعمليات الجراحية والعناية بكبار السن أو الأطفال أو النساء بعد الولادة وغيرها من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، بينما تقتصر الخدمات المقدمة في المحافظة على خدمات العلاج الطبيعي في مراكز متخصصة والتي تتطلبها حالات معينة تنتج عن إصابات الحوادث أو الكسور، في حين تلجأ الحالات الأخرى إلى تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية من المحافظات المجاورة وبالأخص محافظة العاصمة، حيث بلغ عدد مراكز التمريض المنزلي في المملكة بناءً على إحصائيات وزارة الصحة 65 مركزاً منها 53 مركزاً في عمان، في حين بلغ عدد مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل في المملكة 75 مركزاً مستقلاً خارج المستشفيات منهم 51 مركزاً في عمان.

يعتمد تحليل السوق الخاص بخدمات الرعاية الصحية المنزلية على عدة عوامل منها عدد حالات الإدخال في المستشفيات وأعداد العمليات الجراحية وبالأخص التي تحتاج إلى عناية ومتابعة ما بعد العملية ومدى انتشار الأمراض المزمنة وحالات الحروق على مستوى محافظة الزرقاء أو المملكة ككل، ويبين الجدول التالي حجم الإدخالات لقطاع وزارة الصحة والقطاع الخاص في محافظة الزرقاء.

الإدخالات

الجدول 8: إدخالات المستشفيات لعام 2015

قطاع المستشفى	عدد الأسرة	عدد الدخول	عدد الأيام المرضية
مستشفيات وزارة الصحة	674	44960	151146
مستشفيات القطاع الخاص	283	28104	48939
مجموع محافظة الزرقاء	957	73064	200085
مجموع المملكة من القطاعين	8308	641971	1692657
النسبة من المملكة	12%	11%	12%

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، احتساب فرق العمل

كما يبين الجدول التالي الإدخالات المتخصصة في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء، ومن أهمها إدخالات الجراحة والعظام والنسائية والتوليد والمسالك البولية والعناية المركزة والحثثة والتي تعد من أهم حالات الإدخال التي قد تحتاج لخدمات الرعاية الصحية.

الجدول 9: إدخلات مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء والمملكة لعام 2015

البيان	عدد الدخول	عدد الأيام المرضية	نسبة الإدخالات إلى مجموع إدخلات القطاع
الجراحة العامة	8239	27797	18%
العظام	2273	8407	5%
النسائية والتوليد	14600	29262	32%
المسالك البولية	314	729	1%
العناية المركزة ICU	1764	7285	4%
العناية الحثيثة CCU	515	2123	1%
أخرى	17255	75543	38%
المجموع	44960	151146	100%
مجموع المملكة	369538	1154942	
نسبة المحافظة من المملكة	12%	13%	

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، احتساب فرق العمل

كما يبين الجدول التالي مراجعو الإسعاف والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء في العام 2015.

الجدول 10: مراجعو الإسعاف والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2015

البيان	طارئة	غير طارئة	المجموع
مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء	65369	159994	225363
مجموع المملكة	1244605	1732910	2977515
نسبة محافظة الزرقاء من المملكة	5%	9%	8%

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، احتساب فرق العمل

العمليات الجراحية

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية، فإن عمليات جراحة العظام وعمليات التجميل والحروق هي الأكثر حاجة للعناية الخاصة والمتابعة بعد إجراء العمليات، حيث تتطلب الحالات التي تلجأ لمتل هذا النوع من العمليات إلى متابعة وعلاجات إضافية بعد العملية من أجل التعافي التام منها، ويبين الجدول التالي أعداد العمليات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة في محافظة الزرقاء، حيث يلاحظ أن عمليات جراحة العظام قد شكلت حوالي 10% من مجموع

العمليات التي يتم إجرائها في المحافظة، بينما كانت نسبة عمليات الحروق والتجميل من أقل النسب وشكلت حوالي 1% فقط من مجموع العمليات.

الجدول 11: العمليات الجراحية لعام 2015

نوع العملية	مستشفيات وزارة الصحة	مستشفيات القطاع الخاص	مستشفيات محافظة الزرقاء من القطاعين	مستشفيات وزارة صحة في المملكة	مستشفيات القطاع الخاص في المملكة	مجموع المملكة من القطاعين	نسبة إجراء العملية من مجموع العمليات في الزرقاء	نسبة محافظة الزرقاء من إجمالي المملكة
جراحة عامة	2940	5131	8071	17785	38743	56528	34%	14.28%
جراحة صدر وأوعية دموية	0	9	9	829	3005	3834	0%	0.23%
الأعصاب والدماغ	0	145	145	954	4340	5294	1%	2.74%
جراحة العظام	1750	740	2490	10263	13246	23509	10%	10.59%
تجميل وحروق	79	140	219	1073	5439	6512	1%	3.36%
المسالك البولية	458	1169	1627	3624	8671	12295	7%	13.23%
جراحة الأطفال	0	428	428	2855	3965	6820	2%	6.28%
أنف واذن وحنجرة	847	1471	2318	5986	12990	18976	10%	12.22%
جراحة العيون	1100	48	1148	8397	14104	22501	5%	5.10%
جراحة النسائية	3661	3526	7187	33502	28027	61529	30%	11.68%
الفم والفكين	39	58	97	3666	1266	4932	0%	1.97%
أخرى	0	0	0	56	4	60	0%	0.00%
المجموع	10874	12865	23739	89047	133800	222847	100%	10.65%

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، احتساب فرق العمل

تصنف العمليات الجراحية إلى ثلاثة أقسام: عمليات صغرى وعمليات وسطى وعمليات كبرى، حيث تبلغ نسبة العمليات الكبرى على مستوى المملكة 43.84%، بينما تبلغ نسبة العمليات الوسطى 25.7% ونسبة العمليات الصغرى 30.45% وهي نسب متقاربة جداً مع نسب المستشفيات الحكومية في محافظة الزرقاء. ومن الملاحظ أن نسبة العمليات الكبرى والتي هي بحاجة للمتابعة والعناية الخاصة فيما بعدها قد شكلت النسبة الأكبر من العمليات في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء، مما يستدعي وجود خدمات متخصصة للعناية بمثل هذا النوع من العمليات.

الجدول 12: العمليات الجراحية مصنفة حسب درجة العملية في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2015

نوع العملية	مستشفى الزرقاء	مستشفى الأمير فيصل	مجموع المملكة	النسبة المئوية (مملكة)	النسبة المئوية من العمليات (زرقاء)	النسبة المئوية (الزرقاء من المملكة)
صغرى	2515	763	27118	30.45	%30.15	%12.09
وسطى	1826	1065	22888	25.7	%26.59	%12.63
كبرى	3229	1476	39041	43.84	%43.27	%12.05
المجموع	7570	3304	89047	100	%100	%12.21

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، احتساب فرق العمل

حالات الحروق

بلغ نسبة حالات إدخال الحروق في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء حوالي 22% من مجموع حالات الحروق، في حين يتم تحويل ما نسبته 11% من الحالات ومعالجة 67% منها. أما على مستوى المملكة، فقد شكلت نسبة حالات الحروق في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء 2% فقط من مجموع الحالات في المملكة، ويبين الجدول التالي عدد حالات الحروق في مستشفيات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء للعام 2015.

الجدول 13: عدد حالات الحروق في مستشفيات وزارة الصحة 2015

اسم المستشفى	إدخال	معالجة	محول لمستشفى آخر	المجموع
محافظة الزرقاء	60	180	30	270
مجموع المملكة	1467	16380	137	17984
النسبة من المحافظة	%22	%67	%11	%100
نسبة المحافظة من المملكة	%4	%1	%22	%2

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015، احتساب فرق العمل

كبار السن

وفيما يتعلق بالخدمات التي يمكن تقديمها لكبار السن، فقد تبين أن نسبة كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في محافظة الزرقاء بالنسبة إلى المملكة قد بلغت 13%، في حين بلغت نسبة من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً حوالي 11%. ويبين الجدول التالي توزيع الفئات العمرية من كبار السن في محافظة الزرقاء والمملكة في العام 2015.

الجدول 14: توزيع الفئات العمرية من كبار السن في محافظة الزرقاء والمملكة للعام 2015

الفئة العمرية	محافظة الزرقاء	مجموع المملكة	نسبة الفئة العمرية في محافظة الزرقاء	نسبة محافظة الزرقاء من المملكة
65 عام وما فوق	45117	351679	3.3%	13%
80 عام وما فوق	5962	52047	0.4%	11%
مجموع عدد السكان	1364878	9531712	100.0%	14%

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن 2015، احتساب فريق العمل

الأمراض المزمنة

قامت دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسح للأمراض المزمنة خلال الربع الرابع من عام 2010 لعينة ممثلة على مستوى المملكة بلغت حوالي 13 ألف أسرة، حيث تلخصت نتائج المسح بما يلي:

- حوالي 34% من الأسر في الأردن فيها فرد على الأقل يعاني من مرض مزمن
- حوالي 13% من سكان الأردن مصابين بأمراض مزمنة والنسبة بين الإناث أعلى منها بين الذكور
- ارتفاع ضغط الدم هو المرض الأكثر انتشاراً بين الأمراض المزمنة بنسبة بلغت 39%
- حوالي 5% من الأفراد مصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم وحوالي 4% مصابين بمرض السكري
- حوالي 11% من سكان الأردن ممن أعمارهم 25 سنة فأكثر مصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم
- كبار السن هم الأكثر عرضة للأمراض المزمنة بنسبة بلغت حوالي 6% من سكان الأردن
- 95.5% من الأفراد المصابين بأمراض مزمنة يستخدمون الأدوية والعلاجات الموصوفة لهم

إضافةً إلى ذلك، فقد أشارت الدراسة الوطنية لمعرفة مدى انتشار السكري والأمراض المزمنة الأخرى والصادرة عن المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة إلى زيادة نسب الأمراض المزمنة في الأردن، ويبين الجدول التالي انتشار الأمراض المزمنة بما فيها مرض السكري والتوتر الشرياني (ضغط الدم) والسمنة والكولسترول في الأردن في العام 2016.

الجدول 15: انتشار الأمراض المزمنة للفئة العمرية 25 عام فما فوق في الأردن لعام 2016.

المرض المزمن	مستوى المرض حسب القياس المعتمد له	عدد المصابين للفئة العمرية 25 فما فوق في المملكة	نسبة المصابين إلى عدد سكان المملكة من الفئة العمرية 25 فما فوق *
السكري	مستوى السكر أقل من 100	2,403,534	%54.9
	مستوى السكر (100 – 125)	1,112,018	%25.4
	مستوى السكر أكثر أو يساوي 126	862,470	%19.7
ارتفاع التوتر الشرياني	التوتر الشرياني 160/95	1,221,468	%27.9
	التوتر الشرياني 140/90	1,514,796	%34.6
	التوتر الشرياني 135/85	1,851,903	%42.3
السمنة	مؤشر كتلة الجسم أقل من 25	766,154	%17.5
	مؤشر كتلة الجسم (25 – 29)	1,462,259	%33.4
	مؤشر كتلة الجسم أكبر أو يساوي 30	2,149,609	%49.1
الدهنيات	الكوليسترول الكلي	2,110,207	%48.2
	الكوليسترول المرتفع الكثافة	1,611,112	%36.8
	الكوليسترول المنخفض الكثافة	2,092,695	%47.8
	الشحوم الثلاثية	2,022,646	%46.2

المصدر: الدراسة الوطنية لمعرفة مدى انتشار السكري والأمراض المزمنة الأخرى، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.

* تم احتساب النسب بناءً على مجموع عدد سكان المملكة من الفئة العمرية 25 فما فوق والبالغ عددهم 4,378,022 نسمة.

وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان "الأمراض المزمنة غير المعدية، موجز الدول 2014" جاء عن الأردن أن نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة الأربعة التالية والتي لا تنتقل بالعدوى هي كما يلي:

الجدول 16: نسب الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة في الأردن لعام 2014

المرض	النسبة
أمراض القلب والأوعية الدموية	%35
السرطان	%15
أمراض الجهاز التنفسي (الربو والأزمة)	%3
السكري	%7

المصدر: منظمة الصحة العالمية، 2014

أما عوامل الخطورة بين البالغين والتي تزيد من تأثير هذه الأمراض المزمنة، فكانت كما في الجدول التالي.

الجدول 17: عوامل الخطورة التي تزيد في التأثيرات السلبية للأمراض المزمنة.

عامل الخطورة	النسبة بين الذكور (%)	النسبة بين الإناث (%)	النسبة المئوية للمجموع (%)
التدخين	47	6	26
معدل استهلاك الكحول/ الفرد (لتر)	1.2	0.2	0.7
ارتفاع ضغط الدم (2008)	21.1	16.5	18.9
السمنة (2008)	24	36.4	30

المصدر: منظمة الصحة العالمية، موجز الدول 2014 (الأردن، صفحة 100).

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد ارتفع عدد مرضى السكري في العالم من 108 مليون في عام 1980 إلى 422 مليون 2014، كما ارتفع معدل السكري بين البالغين فوق سن 18 من 4.7% إلى 8.5% خلال نفس الفترة وهو أسرع انتشاراً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مثل الأردن. ويعتبر السكري سبباً رئيسياً للعمى (2.6%) والفشل الكلوي والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وفقدان الأطراف السفلى بسبب الغرغرينا. ومن المتوقع أن يكون السكري سابع سبب للوفاة في العالم بحلول عام 2030. حيث أن الأشخاص المصابين بالسكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية بمرتين إلى ثلاث مرات. كما أن نقص التروية مسئول عن بتر واستئصال الأطراف السفلى لديهم. وتجدر الإشارة أن المرضى الذين لا يتناولون أدوية السكري والضغط يشكلون 50% من حالات السكتة الدماغية.

مرض السرطان

أشار تقرير سجل السرطان الوطني للعام 2013 أن المعدل للإصابة بالسرطان بشكل عام لكافة الأعمار قد بلغ 82.9 لكل مائة ألف من السكان (76.1 للذكور، 90.1 للإناث)، في حين بلغ معدل الإصابة الخام للأطفال 103.4 لكل مليون طفل (107.1 للذكور، 99.5 للإناث).

بلغ مجموع الحالات السرطان المسجلة في تقرير سجل السرطان الوطني للعام 2013 والتابع لوزارة الصحة 8744 حالة، شكل الأردنيون منهم ما نسبته 61.9% من إجمالي عدد الحالات، وشكل منهم الذكور الأردنيين 47.3%، في حين بلغت نسبة الإناث 52.7% من مجموع حالات الأردنيين. من جهة أخرى، بلغت نسبة حالات غير الأردنيين 38.1% من مجموع الحالات، ويبين الجدول التالي أعداد حالات السرطان حسب جنسية وجنس الحالة في الأردن للعام 2013.

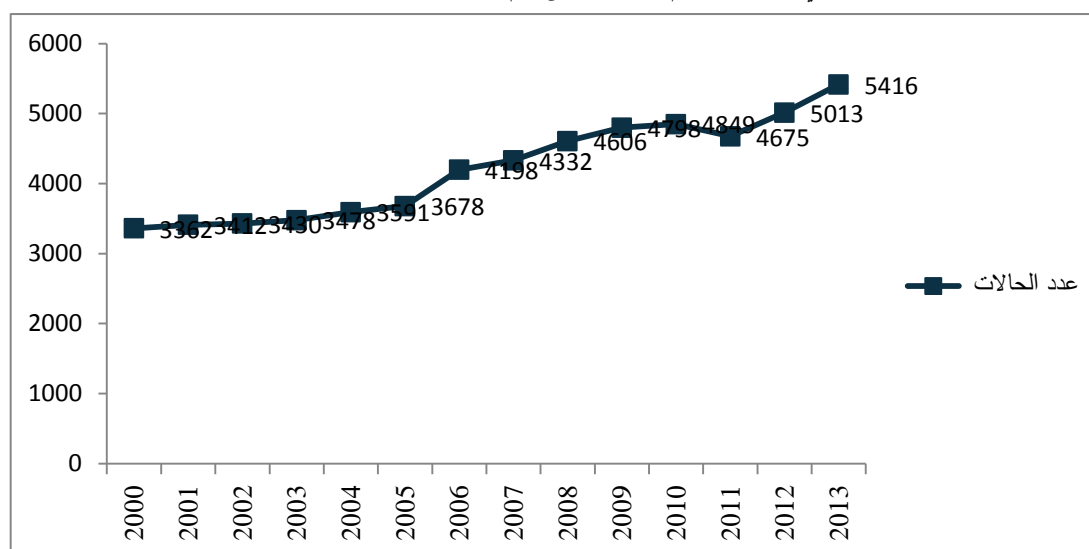
الجدول 18: عدد حالات السرطان حسب الجنسية والجنس في الأردن للعام 2013.

الجنسية/ الجنس	ذكور	إناث	المجموع
الأردنيين	2564	2852	5416
غير الأردنيين	1718	1610	3328
المجموع	4282	4462	8744

المصدر: وزارة الصحة، تقرير سجل السرطان الوطني، 2013

ويبين الشكل التالي أعداد حالات السرطان في الأردن في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2013.

الشكل 4: أعداد حالات السرطان في الأردن منذ عام 2000 وحتى عام 2013.



المصدر: وزارة الصحة، تقرير سجل السرطان الوطني، 2013

كما يبين الجدول التالي أعداد حالات السرطان في الأردن بناءً على الفئات العمرية للحالات وبنسب الحالة.

الجدول 19: عدد حالات السرطان حسب الفئة العمرية والجنس في الأردن للعام 2013.

الفئة العمرية/ الجنس	ذكور	إناث	المجموع
0 – 14 عام	134	118	252
15 – 24 عام	92	112	204
25 – 39 عام	248	440	688
40 – 59 عام	819	1168	1987
60 – 79 عام	1128	897	2025
80 عام أو أكثر	140	111	251
غير معروف	3	6	9
المجموع	2564	2852	5416

المصدر: وزارة الصحة، تقرير سجل السرطان الوطني، 2013

ومن الجدير بالذكر أن السرطانات الخمسة الأكثر شيوعاً بين الذكور هو سرطان القولون والمستقيم حيث شكل 12% من بين حالات الذكور، ثم سرطان الرئة بنسبة 11%، وسرطان المثانة (8.3%)، وسرطان البروستات (7.7%)، ومن ثم سرطان الدم (6.6%).

أما بالنسبة للسرطانات الأكثر شيوعاً بين الإناث، فقد احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة حالاته بين الإناث 36.5%، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 9.4%، وسرطان الغدة الدرقية بنسبة 6.1%، وسرطان الرحم بنسبة 5.3%، وأخيراً سرطانات اللوكيميا بنسبة 4.7% من مجموع السرطانات، ويبين الجداول التالي أكثر عشرة أنواع شائعة من السرطان لحالات الأردنيين في العام 2013.

الجدول 20: أكثر 10 أنواع للسرطان شيوعاً بين الأردنيين للجنسين للعام 2013

نوع السرطان	العدد	النسبة من مجموع حالات الأردنيين
الثدي	1067	19.7%
القولون والمستقيم	593	10.9%
الغدة للمفاوية	401	7.4%
الرئتين	346	6.4%
اللوكيميا	303	5.6%
الغدة الدرقية	233	4.3%
المثانة	231	4.3%
البروستات	197	3.6%
المعدة	175	3.2%
الدماغ	153	2.8%

المصدر: وزارة الصحة، تقرير سجل السرطان الوطني، 2013

تتواجد أغلب حالات السرطان بأنواعها المختلفة في محافظات الوسط من المملكة وخاصةً في عمان والزرقاء، حيث شكلت حالات السرطان في محافظات الوسط نسبة 77.1% من مجموع الحالات، في حين شكلت هذه النسبة 16.1% في محافظات الشمال و5.7% في محافظات الجنوب، ويبين الجدول التالي توزيع حالات السرطان حسب المحافظة والجنس في العام 2013.

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية وجود المشروع المقترح في محافظة الزرقاء من أجل تقديم خدمات التمريض المنزلي لحالات السرطان المتواجدة في المحافظة والمحافظات المجاورة بها والتي تكثر فيها حالات السرطان بشكل كبير بالنسبة لمحافظات المملكة الأخرى.

الجدول 21: عدد حالات السرطان في الأردن حسب المحافظة والجنس لعام 2013

المحافظة/ الجنس	الذكور	الإناث	المجموع
عمان	1587	1766	3353
الزرقاء	227	249	476
البلقاء	123	133	256
مادبا	45	45	90
مجموع محافظات الوسط	1982	2193	4175
اربد	303	342	645
جرش	36	45	81
عجلون	30	29	59
المفرق	45	43	88
مجموع محافظات الشمال	414	459	873
الكرك	68	70	138
العقبة	36	40	76
معان	23	30	53
الطفيلة	16	24	40
مجموع محافظات الجنوب	143	164	307
أخرى	25	36	61
المجموع الكلي	2564	2852	5416

المصدر: وزارة الصحة، تقرير سجل السرطان الوطني، 2013

وفيما يتعلق بأعداد الوفيات الناتجة عن السرطانات باختلاف أنواعها، فإن الجدول التالي يبين هذه الأعداد بناءً على الفئة العمرية للحالات والجنس وذلك في العام 2013.

الجدول 22: أعداد الوفيات الناتجة عن السرطان حسب الجنس والفئة العمرية للعام 2013

الفئة العمرية/ الجنس	ذكور	إناث	المجموع
0 - 14 عام	24	18	42
15 - 24 عام	13	16	29
25 - 39 عام	63	71	134
40 - 59 عام	290	226	516
60 - 79 عام	483	275	758
80 عام أو أكثر	67	53	120
المجموع	940	659	1599

المصدر: وزارة الصحة، تقرير سجل السرطان الوطني، 2013

حجم الطلب

تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب تحديد حجم للطلب على خدمات الرعاية الصحية المنزلية لأسباب كثيرة أهمها أن النمو في الأمراض المزمنة التي تسترعي وجود رعاية منزلية هي في تزايد على مستوى الأردن والعالم ويصعب معها توقع وتيرة هذا التزايد، إضافة إلى زيادة الوعي بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها أو تخفيف أثارها. كما أن معظم هذه الخدمات التي تقدم للمرضى غير مغطاة في التأمين الخاص في الأردن باستثناء العلاج الطبيعي. وعليه، فقد تم تنفيذ مسح ميداني على عينة من أفراد محافظة الزرقاء بلغت 95 شخصاً، حيث تم قياس رضاهم عن خدمات الرعاية الصحية التي يمكن تقديمها عن طريق الشركة وكيفية تلقيها، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول إيجاد شركة متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية الشاملة في مكان واحد متخصص في محافظة الزرقاء. وبناءً على نتائج المسح فقد تبين أن 60% من المستجيبين قد تلقوا خدمات رعاية صحية من قبل.

وفيما يتعلق بكيفية تلقي خدمات الرعاية الصحية، فقد تبين أن 28.6% من المستجيبين قد تلقوا هذه الخدمات من خلال ممرض/ ممرضة، في حين تلقى 21.4% منهم هذه الخدمات من خلال مستشفى عام أو خاص، 20% من خلال طبيب/ طبيبة، 8.6% قد تلقوها في مركز طوارئ 24 ساعة ومثلهم في العيادات الخارجية. كما أن 12.9% منهم قد تلقوها من خلال أخصائي/ أخصائية علاج طبيعي. في المقابل، لم يتلقى أي من المستجيبين هذه الخدمات من خلال شركة متخصصة بالرعاية الصحية المنزلية، ويبين الجدول التالي خدمات الرعاية التي تم تلقيها من قبل المستجيبين.

الجدول 23: خدمات الرعاية الصحية التي تم تلقيها من قبل المستجيبين.

الخدمة	العدد	النسبة من مجموع الخدمات	النسبة من مجموع المستجيبين
إعطاء الإبر	29	19%	31%
قياس الضغط/ السكر	42	28%	44%
أخذ عينات دم	30	20%	32%
العلاج الطبيعي	7	5%	7%
توفير أجهزة طبية للحالة الطبية	0	0%	0%
تركيب كيس بول	3	2%	3%
تنظيف جرح والتغيير عليه	6	4%	6%
تنظيف حروق والتغيير عليها	0	0%	0%
متابعة ومساعدة حالات الكسور	1	1%	1%
مرافقة مريض شيخوخة والعناية به ليلاً/نهاراً	3	2%	3%
العناية بمريض عاجز دوام جزئي/كلي	2	1%	2%

الخدمة	العدد	النسبة من مجموع الخدمات	النسبة من مجموع المستجيبين
العناية بمريض غيبوبة دوام 24 ساعة	0	%0	%0
تركيب كانيولا لإعطاء محاليل وريدية وإعطاء حقن وريدية وأخذ عينات دم	26	%17	%27
ممرضة مرافقة بعد عملية ولادة أو جراحية (قلبية أو محلية)	0	%0	%0
أخرى (مراجعة عامة)	1	%1	%1
المجموع	150 *	%100	

المصدر: المسح الميداني لفريق الدراسة

* يمكن للمستجيب اختيار أكثر من خدمة (عدد المستجيبين الكلي: 95).

إضافةً إلى ذلك، فقد تم سؤال المستجيبين عن آرائهم حول إنشاء شركة متخصصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث أشار 11% منهم إلى موافقتهم وتأييدهم لوجود مثل هذه الشركة في محافظة الزرقاء بشكل كبير. ويبين الجدول التالي الخدمات التي يرغب المستجيبون بتوفيرها من قبل الشركة.

الجدول 24: خدمات الرعاية الصحية التي يرغب المستجيبون بتوفيرها في شركة الرعاية الصحية المنزلية.

الإجابة	العدد	النسبة من مجموع الخدمات	النسبة من مجموع المجيبين على السؤال
التأهيل والعلاج الطبيعي	25	%17	%27.4
متابعة وخدمات حالات العجز الكلي	14	%9	%14.7
متابعة ومرافقة حالات الشيوخوخة	11	%7	%12.6
متابعة وخدمة حالات الغيبوبة	5	%3	%5.3
متابعة وقياس ضغط الدم	20	%13	%22.1
متابعة والعناية بحالات الحروق	9	%6	%9.5
متابعة وخدمة حالات العجز الجزئي	11	%7	%11.6
متابعة والعناية بحالات الكسور والحوادث	4	%3	%5.3
متابعة حالات السكري	10	%7	%11.6

النسبة من مجموع المجيبين على السؤال	النسبة من مجموع الخدمات	العدد	الإجابة
			(القياسات، إعطاء الادوية، معالجة التهابات الاطراف والغيار عليها)
11.6%	7%	11	توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للحالة الطبية
15.8%	9%	14	توفير خدمة الممرض المرافق (يومي / ليلي)
7.4%	5%	7	توفير خدمة الممرض المرافق على مدار الساعة
9.5%	5%	8	توفير خدمة الممرضة المرافقة لفترة وجيزة بعد الولادة أو إجراء عملية جراحية
70	100%	149	المجموع

المصدر: المسح الميداني لفريق الدراسة

* يمكن للمستجيب اختيار أكثر من خدمة.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار مركز خدمات الرعاية الصحية المنزلية، فقد جاءت التوصية من الطبيب الذي يتابع الحالة بالمرتبة الأولى كما يوضح الجدول التالي.

الجدول 25: معايير اختيار شركة خدمات الرعاية الصحية المنزلية

الوزن المرجح (%)	المعيار
25.14	توصية من الطبيب الذي يتابع الحالة
23.76	توصية من المستشفى التي استقبلت وعالجت الحالة
20.62	إعطاء تسهيلات بالدفع
19.90	شهرة وسمعة الشركة
18.67	شهرة الكادر الموجود في الشركة
15.43	بناء على توصية من قريب أو صديق

وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لمتلقي خدمات الرعاية الصحية فيما يتعلق بمدى رضاهم عن الخدمات التي تلقوها بأن هناك رضا عام مرتفع عن هذه الخدمات، حيث أشار 77% من مجموع المستجيبين بأنهم راضون عن جودة الخدمات المقدمة، في حين أشار 69% منهم إلى رضاهم عن أسلوب تعامل الطبيب المشرف و63% منهم إلى رضاهم عن النظافة والتعقيم.

لمحة عن المنافسين الرئيسيين

يبين هذا الجزء من الدراسة المنافسين الرئيسيين من مراكز الرعاية الصحية المنزلية ومراكز العلاج الحكي (الطبيعي والوظيفي) في محافظة الزرقاء، وبعض المراكز المماثلة الموجودة في عمان. ومن الجدير بالذكر أن محافظة الزرقاء تفتقر لوجود شركات متخصصة بالتمريض المنزلي حيث توجد حالياً شركة تعمل بشكل جزئي في مدينة الزرقاء من خلال فرعها الرئيسي في الشميساني (عمان) ومؤسسة بيع أجهزة ومستلزمات طبية في الزرقاء وتؤمن احتياجات الزبائن بناءً على الطلب، كما يوجد عدد من مراكز العلاج الطبيعي تنقسم أهدافها لأغراض تعليمية وربحية ومؤسسات مجتمع مدني، وفيما يلي أهم المعلومات التي توفرت عنها.

اسم المركز	نور العين للتمريض المنزلي
الموقع	الأردن، عمان - الشميساني/ الزرقاء (من خلال بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية)
الوصف العام	يقدم مركز نور العين خدمات التمريض المنزلي من خلال الفرع الرئيسي في عمان، ويقدم خدماته للحالات اليومية والحالات التي تتطلب العناية المركزة. إضافة إلى خدمات المبيت في منازل الحالات المزمدة وأيضاً للحالات العادية والتي تتطلب عناية مركزة.
الخدمات المقدمة	يقدم المركز خدمات التمريض المنزلي لنوعين من الحالات، حالات عادية تتطلب خدمات تمريضية أساسية في منزل الحالة وحالات تتطلب العناية المركزة، بالإضافة إلى المبيت في منازل الحالات سواءً للحالات العادية أو حالات العناية المركزة.
الأسعار	أسعار الحالات العادية في منزل المريض: 8 ساعات باليوم: 12 دينار 12 ساعة باليوم: 35 دينار 24 ساعة: 50 دينار أسعار حالات العناية المركزة في منزل المريض: 8 ساعات باليوم: 25 دينار 12 ساعة باليوم: 45 دينار 24 ساعة: 70 دينار

اسم المركز	مركز البيدر للعلاج الطبيعي
الموقع	الأردن، الزرقاء - بالقرب من مستشفى جبل الزيتون
الوصف العام	يتكون المركز من غرفتين للعلاج وغرفة استقبال وغرفة للإدارة وتبلغ مساحته 170 متراً مربعاً تقريباً.
الخدمات المقدمة	يقدم المركز خدمات العلاج الطبيعي لكل مما يلي: ■ العضلات ■ إصابات العظام ■ الأعصاب والنخاع الشوكي ■ الإصابات الرياضية
سعر الجلسة	10 - 15 دينار بحسب الحالة

اسم المركز	مركز الإبداع للعلاج الطبيعي
الموقع	الأردن، الزرقاء الجديدة - شارع 36
الوصف العام	يتكون المركز من أربعة معالين يقدمون خدمات العلاج الطبيعي، حيث يقوم المركز باستقبال 250 - 300 حالة شهرياً.
الخدمات المقدمة	يقدم المركز خدمات العلاج الطبيعي لكل مما يلي: ■ العضلات ■ إصابات العظام ■ إصابات النخاع الشوكي والأعصاب ■ علاج الأطفال
سعر الجلسة	10 - 15 دينار

اسم المركز	مركز بصمة أمل للعلاج الطبيعي
الموقع	الأردن، الزرقاء - الرصيفة - حي الرشيد
الوصف العام	يتكون المركز من اثنين من المعالين يمتلكان المركز ويقدمان خدمات العلاج الطبيعي، حيث يقوم المركز باستقبال حوالي 150 حالة شهرياً.
الخدمات المقدمة	يقدم المركز خدمات العلاج الطبيعي لكل مما يلي: ■ العضلات ■ إصابات العظام ■ الإصابات الرياضية ■ علاج الأطفال ■ علاج الأعصاب والنخاع الشوكي
سعر الجلسة	15 ديناراً

اسم المركز	البتراوي الحديث للعلاج الطبيعي
الموقع	الأردن، الزرقاء - الكرامة - دوار الفلاح
الوصف العام	تبلغ مساحة المركز حوالي 170 متر مربع، ويتكون من غرفة استقبال وغرفة علاج طبيعي للأطفال وغرفتين للعلاج بالإضافة إلى غرفة للعلاج المائي.
الخدمات المقدمة	يقدم المركز خدمات العلاج الطبيعي لكل مما يلي: ■ علاج الأطفال ■ العلاج الطبيعي بكافة أنواعه ■ علاج إصابات النخاع الشوكي ■ علاج إصابات العظام والعضلات
سعر الجلسة	10 - 15 دينار

اسم المركز	ياجوز التخصصي للعلاج الطبيعي
الموقع	الأردن، ياجوز - الجبل الشمالي
الوصف العام	يتكون المركز من غرفتين للعلاج الطبيعي وغرفة استقبال
الخدمات المقدمة	يقدم المركز خدمات العلاج الطبيعي لكل مما يلي: ■ إصابات العظام والعضلات ■ علاج الأعصاب ■ الإصابات الرياضية ■ إصابات النخاع الشوكي
سعر الجلسة	10 دنانير

اسم المركز	السكنية للرعاية التمريضية المنزلية
الموقع	الأردن، عمان
الوصف العام	تقدم شركة السكنية خدمات التمريض المنزلي باعتماد وترخيص من وزارة الصحة الأردنية وتقدم مجموعة من خدمات الرعاية التمريضية، وخدمات العناية الخاصة في بيئة المنزل. وتشتمل خدماتها على إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، والعناية بالجروح، والرعاية بعد القسطرة البولية، والعناية بفتحات البراز خارج جدار البطن، والعلاج بالحقن الوريدية في المنزل، والعناية بالتقرحات الجلدية، ورعاية مرضى السكري، والأمومة وحديثي الولادة. كما تضم خدمات العلاج النفسي، والعلاج التنفسي، والتحويل إلى المستشفيات عند الضرورة، والتنسيق مع خدمات سيارات الإسعاف، أما خدمات العناية المنزلية فهي عبارة عن خدمات الرعاية غير الطبية والتي تقدمها مجموعة من مساعدات التمريض ومقدمي الخدمة وذلك من أجل مساعدة كبار السن، والمعاقين، والمرضى على الاستشفاء والنفاة في بيوتهم الخاصة ومنها المساعدة في الاستحمام والتزين، ومراقبة الحمية وعادات الأكل، والمساعدة في الوجبات الغذائية والمشى والتنقل، والتذكير بمواعيد الدواء والتمارين الرياضية لتحسين حركة المفاصل، ومراقبة المرضى لزيارة الأطباء، والمصاحبة وتبادل الحديث.
الخدمات المقدمة	- التمريض المنزلي - العناية الخاصة - العلاج الطبيعي - الإقامة على نظام الفترتين الصباحية والمسائية - توفير المستلزمات الطبية
سعر الجلسة	- الفترة الصباحية (8 صباحاً - 6 مساءً) مع ممرضة: 30 دينار - الفترة الصباحية (8 صباحاً - 6 مساءً) مع مرافقة: 25 دينار - فترة 24 ساعة مع ممرضة: 50 دينار - فترة 24 ساعة مع مرافقة: 40 دينار

اسم المركز	رئسي للخدمات الطبية
الموقع	الأردن، عمان - الشميساني
الوصف العام	شركة متخصصة بالعناية بصحة المرضى وتلبية جميع احتياجاتهم في منازلهم ضمن معايير وزارة الصحة الأردنية من خلال توفيرها لما يزيد عن 20 خدمة طبية من قبل أكثر من 100 كادر طبي، كما توفر الشركة أكثر من 5000 جهاز طبي للمرضى. وبالإضافة للخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها الشركة، فهي تقدم خدمة نقل المرضى من المستشفيات إلى المنازل وعبر كافة محافظات المملكة، بالإضافة إلى نقل المرضى من الجسر الأردني الفلسطيني، ونقل المرضى إلى دول الخليج العربي ودول شمال أفريقيا. كما قامت الشركة بتخصيص قسم خاص لتقديم العناية الصحية الفائقة للمرضى من جميع انحاء العالم تحت

مفهوم السياحة العلاجية، حيث يتم المساعدة بجميع الإجراءات الإدارية واللوجستية كترتيب المواعيد والاستشارات والإقامة لمرافقي المرضى بالإضافة إلى المساعدة في أي إجراءات مالية وتوفير خدمات الترجمة الفورية إذا دعت الحاجة لذلك.	
▪ التمريض المنزلي ▪ العلاج الطبيعي ▪ نقل المرضى ▪ مرافقة الأطفال ▪ توفير الأجهزة الطبية ▪ التصوير الإشعاعي ▪ التحاليل الطبية ▪ العناية بالجروح والتقرحات ▪ العناية بالقدم والسكري ▪ إعطاء الحقن الوريدية والعضلية ▪ التنظيم الغذائي ▪ العناية الشخصية ▪ السياحة العلاجية	الخدمات المقدمة

المجد للخدمات التمريضية	اسم المركز
الأردن، عمان - المدينة الرياضية	الموقع
تقدم شركة المجد للخدمات التمريضية المنزلية في منازل المرضى إما عن طريق تقديم خدمات محددة من خلال زيارات مستقلة أو من خلال المبيت في منازل المرضى ورعايتهم ومراقبتهم لمدة معينة من اليوم أو على مدار اليوم كامل، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة للمرضى.	الوصف العام
▪ التمريض المنزلي ▪ توفير الأجهزة الطبية	الخدمات المقدمة
▪ نظام صباحي/ مسائي 12 ساعة: 35 دينار ▪ نظام 24 ساعة بدوام كامل أو فترتين: 60 دينار ▪ مرافقة تمريضية على مدار الساعة: 1300 دينار شهرياً ▪ زيارة المريض لإعطاء إبر أو تركيب مغذيات أو أكياس بول وغيرها: 25 دينار ▪ إيجار سرير المريض: 100 دينار شهرياً	سعر الجلسة

ومن الجدير بالذكر أن مركز الحسين للسرطان يتكون من قسم لرعاية مرضى السرطان في منازلهم وهو قسم العناية التلطيفية، وهو ما يؤكد على أهمية وجود خدمة للعناية بمرضى السرطان خارج المستشفيات وخصوصاً في مراحل المرض المتقدمة، وفيما يلي بعض المعلومات المتعلقة بهذا القسم.

اسم المركز	مركز الحسين للسرطان - قسم العناية التلطيفية
الموقع	الأردن، عمان - مركز الحسين للسرطان
الوصف العام	ينقسم الكادر التمريضي في قسم العناية التلطيفية في مركز الحسين للسرطان إلى نوعين وهما التمريض الداخلي والتمريض الخارجي. يهتم الكادر الداخلي بإعطاء العلاج لمرضى السرطان داخل المركز، ويتكون من رئيس للقسم وخمسة مشرفين وخمسة ممرضين وست ممرضات بالإضافة إلى ثلاثة ممرضين مشاركين، بينما يتكون الكادر الخارجي للقسم من أربعة فرق يشمل الفريق الواحد منهم 2 - 3 ممرضين من كلا الجنسين. يقدم المركز العلاج الخارجي لمرضى السرطان في منازلهم شريطة أن يكون المريض قد تلقى علاجه سابقاً لدى المركز أي أن يكون أحدى مرضاه، وأن تكون حالة المريض محولة من مستشاري قسم العناية التلطيفية، إضافة إلى أن يكون المريض في المرحلة الرابعة من مرضه (مرحلة نقشي المرض في الجسم).
الخدمات المقدمة	تشمل خدمات العناية التلطيفية التي يتلقاها المريض في منزله علاج الألم الكبير وإعطاء المضادات الحيوية في حال وجود التهابات لدى المريض وإعطاء خافض للحرارة بالإضافة إلى إعطاء أدوية الضوجان لهم وغيرها من الخدمات الأخرى.
سعر الجلسة	يتم دفع مبلغ 20 دينار عند الزيارة الأولى للمريض ومبلغ 12 دينار للزيارات اللاحقة (المراجعات)، بالإضافة إلى دفع قيمة تأمين تبلغ 50 دينار.

3.5 تحليل الأسعار

أظهرت نتائج المسح الميداني الذي تم إجراؤه في محافظة الزرقاء على عينة من المستجيبين متوسط أسعار خدمات الرعاية الصحية التي تلقوها، ويبيّن الجدول التالي تحليل أسعار خدمات الرعاية الصحية المنزلية في محافظة الزرقاء.

الجدول 26: تحليل أسعار خدمات الرعاية الصحية المنزلية

الخدمة	متوسط سعر الجلسة (دينار)	متوسط الأجر الشهري (دينار)
تأهيل وعلاج طبيعى داخل مركز الشركة	17.19	100
تأهيل وعلاج طبيعى داخل المنزل	17.71	175
متابعة ومرافقة حالات الشيخوخة	17.8	521
متابعة وخدمة حالات الغيبوبة	16	425
متابعة والعناية بحالات الحروق	13.47	220
متابعة وخدمات حالات العجز الكلي	15.2	540
متابعة وخدمة حالات العجز الجزئي	17.4	325
متابعة والعناية بحالات الكسور والحوادث	14.38	325
متابعة حالات السكري (القياسات، إعطاء الادوية، معالجة التهابات الاطراف والغيار عليها	10.44	130
توفير خدمة الممرض المرافق يومي/ ليلي	21.5	427.78

3.6 الاستراتيجية التسويقية

السوق المستهدف

يستهدف المشروع الزبائن التالية:

- المرضى الأردنيين وخاصة من محافظة الزرقاء ومحافظة المملكة والذين لديهم حالات تتطلب خدمات الرعاية الصحية المنزلية مثل حالات متابعة الضغط والسكري ومضاعفاتهما والعناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية والكسور والحروق والحوادث
- كبار السن والمصابين بعجز جزئي أو كلي من محافظة الزرقاء ومحافظة المملكة
- حالات الأمراض المزمنة في محافظة الزرقاء ومحافظة المملكة
- المصابين بحالات تتطلب معالجة حكيمة (علاج طبيعي أو وظيفي) مثل المصابين بالديسك والشد العضلي والذين يجرون عمليات تغيير مفصل.

الخدمات والمنتجات المتوقعة

تشمل خدمات المشروع المتوقعة ما يلي:

- تقديم خدمات التمريض المرافق للمريض في المنزل على مدار الساعة وذلك للحالات المستعصية والمزمنة مثل حالات الغيبوبة الدماغية وكبار السن، حيث يتم تأمين المريض بمرضى/ ممرضة مرافقة على وريتين (إيلي/ نهاري) وذلك للقيام بتأدية المهام والخدمات التالية للمريض:
- توفير الأجهزة الطبية للحالات المستعصية مثل السرير الطبي، جهاز التنفس، جهاز سحب البلغم suction، جهاز قياس الضغط، جهاز قياس السكر، الشراشف الخاصة، أكياس البول، المحاليل الوريدية، الكانيولا، المستلزمات الطبية مثل القطن والحقن وغيرها.
- القيام بمتابعة المرضى في المنزل وقياس الضغط والسكر وتركيب الكانيولا لأخذ عينات الدم، وأخذ عينات البول لفحصها بين الحين والآخر... الخ
- تنظيف المريض والمساعدة بتغسيله
- العمل على راحة المريض في المنزل ومراقبة حالته الصحية
- إعطاء المريض أدويته بانتظام وبحسب تعليمات الطبيب المشرف على الحالة
- إعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية، والعناية بالجروح، والرعاية بعد القسرة البولية والعناية بالنقرحات الجلدية
- العناية بفتحات البراز خارج جدار البطن
- العلاج بالحقن الوريدية في المنزل
- رعاية مرضى السكري
- العلاج النفسي، والعلاج التنفسي، والتحويل إلى المستشفيات عند الضرورة

- التنسيق مع خدمات سيارات الإسعاف
- خدمات الرعاية غير الطبية والتي تقدمها مجموعة من مساعدات التمريض ومقدمي الخدمة وذلك من أجل مساعدة كبار السن، والمعاقين، والمرضى على الاستشفاء والنفاضة في بيوتهم الخاصة ومنها المساعدة في الاستحمام والتزين، ومراقبة الحمية وعادات الأكل، والمساعدة في الوجبات الغذائية والمشى والتنقل، والتذكير بمواعيد الدواء والتمارين الرياضية لتحسين حركة المفاصل، ومرافقة المرضى لزيارة الأطباء، والمصاحبة وتبادل الحديث.
- العلاج الحكي (العلاج الطبيعي والوظيفي) ويشمل:
 - تأهيل أمراض وإصابات النخاع الشوكي والعمود الفقري
 - تأهيل أمراض الجهاز العضلي - الحركي
 - تأهيل أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام
 - تأهيل الاصابات الرياضية والشد العضلي

الأسعار المتوقعة

يبين الجدول التالي الأسعار المقترحة لخدمات الرعاية الصحية المنزلية وذلك بناء على نتائج مسح السوق وتحليل المنافسين، مع الأخذ بالاعتبار أن المستجيبين للمسح الميداني غالباً ما يطالبون بأسعار أقل بحوالي 20 - 30% مما هم مستعدون لدفعه مقابل الخدمات التي يتلقونها.

الجدول 27: الأسعار المتوقعة لخدمات التمريض المنزلي

الأسعار (دينار أردني)	البيان
450 دينار سنوياً	متابعة الحالات المنزلية البسيطة شهرياً مثل السكري والضغط والجروح والحروق...الخ/ الزيارة لمدة ساعة وبمعدل 60 زيارة سنوياً
25 دينار/ الزيارة	متابعة الحالات اليومية التي تحتاج إلى عناية مستمرة مثل كبار السن والعظام والكسور والعجز الجزئي ولكن لفترة محدودة (مدة الزيارة لا تقل عن 8 ساعات في الغالب)
650 دينار شهرياً	متابعة الحالات الشهرية التي تحتاج إلى عناية مستمرة ولكن بشكل جزئي (مدة الزيارة 8 - 12 ساعة في الغالب)
1200 دينار شهرياً	متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة على مدار الساعة مثل الغيبوبة والعجز الكلي (ورديتين مدة كل وردية 12 ساعة)

ويبين الجدول التالي الأسعار المقترحة لخدمات العلاج الحكي (الطبيعي والوظيفي).

الجدول 28: الأسعار المتوقعة لخدمات العلاج الحكي

البيان	النسبة من الحالات (%)	الكلفة للجلسة داخل المركز (دينار)	الكلفة للجلسة في المنزل (دينار)
تأهيل أمراض وإصابات النخاع الشوكي والعمود الفقري	20	15	20
تأهيل أمراض الجهاز العضلي - الحركي	40	10	15
تأهيل الأطراف والروماتيزم وهشاشة العظام	20	10	15
تأهيل الإصابات الرياضية والشد العضلي	20	10	15
متوسط كلفة الجلسة	100	11	16

الترويج

تشتمل الاستراتيجية الترويجية للمشروع كما يلي:

- وجود مدير فني ذي خبرة ويستطيع إدارة الكادر الفني من الممرضين والممرضات القانونيين ومساعدتهم
- وجود مدير فني مختص في العلاج الحكي ولديه خبرة جيدة في المجال والمقدرة على إدارة المعالجين الموجودين في المركز
- التركيز على أطباء الاختصاص في الحالات التي تتطلب خدمات الرعاية الصحية (مثل أطباء العظام والباطني والقلب والأعصاب) في محافظة الزرقاء ومحيطها وذلك لتحويل مرضاهم إلى الشركة
- التركيز على شركات التأمين وإعطائهم مزايا كخصومات الأسعار وتسهيلات الدفع. ووضع إعلانات في كتيبات شركات التأمين وإبراز المزايا التي تتمتع بها الشركة حيث أنها الأولى من نوعها في المحافظة التي تختص بكافة خدمات الرعاية الصحية في مكان واحد
- وضع إعلانات في المستشفيات والعيادات المتخصصة
- تصميم موقع إلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
- بروشورات للشركة والخدمات التي تقدمها
- الإعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى في بداية المشروع
- وضع لوحات إعلانات على الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى الشركة

البيع

تشتمل استراتيجية البيع للمشروع على ما يلي:

- الاستقبال المباشر للمرضى والحالات
- الزيارات المتكررة للحالات في منازلها أو الإقامة في منزل المريض
- التعاقد مع شركات التأمين
- ويمكن التوجه نحو التعاقد مع المستشفيات والعيادات المتخصصة بالحالات التي تتطلب خدمات الرعاية الصحية
- التعاقد مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية مثل الجمعيات الخيرية ووضع حزم خاصة بها وبأسعار تفضيلية لخدمة مستفيديها من الحالات اليومية والشهرية والمزمنة سواء كانت عادية أم عجز جزئي أو كلي

الخدمات

تشتمل استراتيجية تقديم الخدمات للمشروع كما يلي:

- وجود أطباء وممرضين ذوي خبرة واسعة وسمعة جيدة في الشركة
- المهنية العالية والتركيز على جودة الخدمات والمواد المستخدمة
- المصادقية في التعامل والتواجد بمجرد الطلب (سرعة الاستجابة)
- وجود عدد كافي من الموظفين ومقدمي الخدمات للعناية بالمرضى وذويهم / مرافقيهم
- تعاون فعال ومشترك مع الأطباء والمستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى
- عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية (الجمعيات الخيرية)
- الحصول على جميع شهادات الجودة والاعتماد ذات العلاقة (محلياً ودولياً)
- الاشتراك في جمعيات الأعمال ذات العلاقة وذلك للاستفادة من برامج التطوير التي تتيحها للأعضاء
- العناية الفائقة بالمريض والنظافة الدائمة والمستمرة
- احترام قواعد حفظ الصحة والنظافة والسلامة العامة
- صيانة التجهيزات بشكل مستمر
- الإهتمام بالمظهر اللائق للموظفين ومقدمي الخدمات
- الإهتمام بالمعاملة الحسنة واللائقة مع الزبائن وذويهم أو مرافقيهم سواء في منازلهم أو داخل مركز العلاج الحكومي
- الإهتمام بسرعة تقديم الخدمة للمرضى

3.5 حجم الطلب المتوقع

للوصول إلى مؤشرات عن حجم السوق لبعض خدمات الرعاية الصحية المنزلية، فقد تمت الاستفادة من بيانات دائرة الإحصاءات العامة والمسوحات الميدانية التي قام بها كل من المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، وكذلك فريق الدراسة ودائرة الإحصاءات العامة واعتماد الحقائق العلمية حول الأمراض المزمنة وأثارها الواردة أعلاه. والجدول التالي يبين حجم الطلب المتوقع على أهم خدمات الرعاية الصحية (متابعة مرضى الضغط والسكري والعناية بهم، إضافة إلى حالات العجز الجزئي والغيوبية الناتجة عن هذه الحالات) للسنة الأولى فقط كون معدلات النمو لهذه الأمراض غير معروفة محلياً وعالمياً.

الجدول 29: مؤشرات أولية لتحديد حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية المنزلية للسنة الأولى من المشروع

البيان	2015	2016	2017	2018 (التاريخ المتوقع لبدء عمل الشركة)	عدد المصابين بمرض الضغط (5% من السكان)*	عدد المصابين المحتملين بمرض السكري (4% من السكان)*	مجموع من سيحتاجون عناية خاصة
عدد سكان محافظة الزرقاء	1,368,800	1,407,400	1,447,089	1,487,897	74,395	59,516	-
عدد سكان المملكة	5,531,712	5,687,706	5,848,100	6,013,016	300,651	240,521	-
عدد المصابين بضغط / سكري من ذوي القراءة الحرجة بحسب دراسة المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة (27.9% و 19.7% على التوالي). هذا الرقم يمثل جميع المرضى الذين قد يستخدمون خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمتابعة بين الحين والآخر.				الزرقاء	20,756	11,725	32,481
				المملكة	83,882	47,383	131,264
عدد من لا يتناولون الأدوية والعلاجات الموصوفة لهم (4.5%) بحسب دراسة الإحصاءات العامة				الزرقاء	934	528	1,462
				المملكة	3,775	2,132	5,907
عدد المعرضين للإصابة بالسكتة الدماغية (50%) ممن لا يتناولون أدويةهم وبالتالي فهم بحاجة إلى عناية فائقة إما بشكل جزئي أو كلي				الزرقاء	467	264	731
				المملكة	1,887	1,066	2,953

المصدر: المسوحات الميدانية لدائرة الإحصاءات العامة وفريق الدراسة؛ إضافة إلى الدراسة الوطنية لمعرفة مدى انتشار السكري والأمراض المزمنة الأخرى، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.

* مسح الأمراض المزمنة، دائرة الإحصاءات العامة 2011

كما سبق ذكره، فإنه من الصعب تحديد حجم الطلب على خدمات المشروع المقترح وإن تم الوصول إلى بعض التوقعات للسنة الأولى فمن الصعب توقع معدلات النمو على الطلب على هذه الخدمات وذلك بسبب ازدياد الأمراض المزمنة على مستوى العالم والأردن بشكل يصعب معه توقع معدلات النمو. وبما أنه لا توجد شركات تقدم خدمات متكاملة مثل خدمات

المشروع في محافظة الزرقاء وبالتالي تقاس حصته السوقية بطاقته التصميمية أو قدرته على استيعاب المستفيدين من خدمات الشركة المحتملين.

وبين الجدول التالي حجم الطلب المتوقع في السنة الأولى.

الجدول 30: حجم الطلب المتوقع للسنة الأولى

البيان	عدد الحالات (حجم الطلب المتوقع)	عدد الزيارات
متابعة الحالات المنزلية البسيطة شهرياً مثل السكري والضغط والجروح والحروق... الخ / الزيارة لمدة ساعة ويمعدل 60 زيارة سنوياً	255	60
متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة مثل كبار السن والعظام والكسور والعجز الجزئي ولكن لفترة محدودة (مدة الزيارة لا تقل عن 8 ساعات في الغالب)	6	104
متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة ولكن بشكل جزئي (مدة الزيارة 8 - 12 ساعة في الغالب)	9	3 أشهر خلال السنة
متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة على مدار الساعة مثل الغيبوبة والعجز الكلي (ورديتين مدة كل ورديّة 12 ساعة)	4	على مدار السنة

وفيما يتعلق بمركز العلاج الحكي (الطبيعي والوظيفي)، فقد تم تصميمه بحيث يتم استيعاب 75% من الحالات داخل المركز و 25% من الحالات داخل المنازل.

4. الدراسة الفنية للمشروع

4.1 الطاقة التصميمية للمشروع

يبين الجدول التالي الطاقة التصميمية للمشروع، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع..

الجدول 31: الطاقة التصميمية للمشروع

عدد الحالات سنوياً	البند
310 حالة وبمعدل 60 زيارة سنوية لكل حالة	متابعة الحالات المنزلية البسيطة شهرياً مثل السكري والضغط والجروح والحروق...الخ/ الزيارة لمدة ساعة وبمعدل 60 زيارة سنوياً
12 حالة سنوياً وبمتوسط 104 زيارة لكل حالة	متابعة الحالات اليومية التي تحتاج إلى عناية مستمرة مثل كبار السن والعظام والكسور والعجز الجزئي ولكن لفترة محدودة (مدة الزيارة لا تقل عن 8 ساعات في الغالب)
13 حالات سنوياً وبمتوسط 6 شهور في السنة لكل حالة	متابعة الحالات الشهرية التي تحتاج إلى عناية مستمرة ولكن بشكل جزئي (مدة الزيارة 8 - 12 ساعة في الغالب)
4 حالة سنوياً طوال العام	متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة على مدار الساعة مثل الغيبوبة والعجز الكلي (ورديتين مدة كل ورديّة 12 ساعة)
4500 حالة/ جلسة	حالات العلاج الطبيعي والوظيفي داخل المركز
1500 حالة/ جلسة	حالات العلاج الطبيعي والوظيفي داخل المنازل

ومن أجل الوصول إلى الطاقة التصميمية فإنه يتطلب استئجار مبنيين منفصلين (بحسب تعليمات وزارة الصحة) مساحة الأول 80 م² ويخصص لخدمات التمريض المنزلي والآخر بمساحة 170 م² ويخصص لمركز العلاج الحركي، وإجراء التعديلات المناسبة على المباني والديكورات، ويمكن التوسع مستقبلاً من خلال استئجار مساحات أوسع أو فتح فروع أخرى داخل المحافظة. ويتطلب مركز العلاج الطبيعي والوظيفي وجود 4 غرف للعلاج يمكن تخصيص إحداها للنساء وأخرى للأطفال، إضافة إلى غرفة العلاج المائي وصالة الأجهزة والتمارين الرياضية، كما توجد صالة إنتظار وغرف للإدارة والمعالجين/ الأخصائيين.

4.2 الموارد المادية المطلوبة

يبين الجدول التالي إجمالي تكلفة الأصول الثابتة والتي بلغت 177.5 ألف دينار.

الجدول 32: إجمالي تكلفة الأصول الثابتة للمركز *

البند	الوحدة	السعر (دينار)	القيمة (دينار)
تعديلات على المبنى وديكورات	250	50	12,500
الأجهزة والمعدات لمركز العلاج الطبيعي	-	-	60,000
الأجهزة والمعدات للتمريض المنزلي	-	-	10,000
أثاث	-	-	30,000
تقنية معلومات	-	-	25,000
وسائط نقل	4	-	40,000
المجموع			177,500

* تم تقدير الأرقام من واقع دراسة السوق

** تشمل الأرقام تكلفة جميع مستلزمات البنية التحتية وأعمال الكهروميكانيك.

ويبين الجدول التالي أهم تفاصيل الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز مركز العلاج الطبيعي والوظيفي.

الجدول 33: أهم الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز مركز العلاج الطبيعي والوظيفي وتكاليفها المتوقعة

البيان	العدد	السعر (دينار)	التكلفة الاجمالية (دينار)
جهاز تمارين الكاثل	1	2,000	2,000
أثقال للكاثل	مجموعة كاملة	100	100
وحدة الشد العنقي	1	1,500	1,500
جهاز تسخين الكمادات	1	200	200
جهاز التسخين بالذرات	1	1,000	1,000
جهاز بسكليت ثابت يدوي	1	500	500
جهاز بسكليت ثابت اتوماتيك	1	5,000	5,000
حوض مائي للطرف العلوي	1	2,500	2,500
حوض مائي للطرف السفلي	1	2,500	2,500
ماكينة تصنع الثلج مع ملحقاتها أو جهاز كمادات باردة	1	200	200
جهاز العلاج بالأشعة تحت الحمراء (كبير)	1	600	600

البيان	العدد	السعر (دينار)	التكلفة الاجمالية (دينار)
جهاز علاج بالتيار المتداخل	1	700	700
مرآة	1	100	100
جهاز التنبيه الكهربائي (منخفض ومتوسط)	1	700	700
جهاز علاج بالشمع	1	100	100
جهاز المشي المتوازي	1	300	300
جهاز تقوية العضلات الرباعية (جهاز استطالة الرجل)	1	3,000	3,000
جهاز زيادة المدى الحركي للكتف	1	1,500	1,500
الدرج العلاجي (1 كهربائي + 1 عادي)	2	5,000	10,000
جهاز تمارين تقوية العضلات بالأوزان (Adjustable)	1	10,000	10,000
طاولة الميلان للتوازن	1	300	300
علاج الأمواج فوق الصوتية (لداخل وخارج المركز)	2	1,000	2,000
سلم جداري	1	200	200
كرسي متحرك (2 عادي + 1 متحرك)	3	700	2,100
سرير عادي للعلاج الطبيعي	4	100	400
آلة سحب العمود الفقري Traction Machine	1	4,000	4,000
كيس رمل ساخن	2	50	100
جهاز حديث للركض	1	4,000	4,000
طقم أثقال (من 0.5 - 15 كغم)	2	1,000	2,000
جهاز العلاج بالأشعة تحت الحمراء متنقل (صغير)	4	15	60
جهاز علاج بالتيار المتداخل (صغير / متنقل)	2	100	200
مناشف	مجموعة متنوعة	200	200
أجهزة ومعدات متنوعة أخرى	-	1940	1940
المجموع			60,000

كما يبين الجدول التالي أهم تفاصيل الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز شركة خدمات التمريض المنزلي.

الجدول 34: أهم الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز شركة التمريض المنزلي وتكاليفها المتوقعة

البيان	العدد	السعر (دينار)	التكلفة الإجمالية (دينار)
سرير طبي	1	1,000	1,000
جهاز تنفس اصطناعي	1	500	500
جهاز تبخيرة	4	50	200
جهاز سحب البلغم	4	100	400
اسطوانة اكسجين	1	150	150
حقيبة تمريض كاملة لكل مريض (جهاز قياس ضغط، جهاز قياس سكر، سماعة طبية، مطرقة، مصباح، مقصات طبية، مستلزمات طبية مثل اسرنجات وكفوف طبية وقطن وكحول طبي...الخ)	18	300	7,200
ستاند تعليق لكيس المحلول المغذي IV Solution	1	50	50
مستلزمات أخرى للمرضى	-		500
المجموع			10,000

4.3 الموارد البشرية المطلوبة

يبين الجدول التالي الموارد البشرية المطلوبة للمشروع، حيث يبلغ عدد الموظفين المطلوب حوالي 33 موظفاً بإجمالي رواتب 187,440 دينار أردني.

الجدول 35: الموارد البشرية المطلوبة للمشروع

البيان	عدد الموظفين	الراتب (دينار/ شهرياً)	إجمالي الراتب (دينار/ سنوياً)	التشغيلي (دينار/ سنوياً)	الإداري (دينار/ سنوياً)
مدير عام	1	1200	14,400	14,400	-
سكرتاريا	1	300	3,600	3,600	-
رئيس قسم الرعاية الصحية المنزلية (مدير فني/ طبيب مقيم/ ممرض قانوني)	1	800	9,600	-	9,600
رئيس قسم المعالجة الحكيمة (أخصائي علاج)	1	800	9,600	-	9,600

البند	عدد الموظفين	الراتب (دينار/ شهرياً)	إجمالي الراتب (دينار/ سنوياً)	التشغيلي (دينار/ سنوياً)	الإداري (دينار/ سنوياً)
طبيعي/ وظيفي)					
أخصائي/ أخصائية علاج طبيعي	4	450	21,600	-	21,600
ممرض/ ممرضة	22	450	118,800	-	118,800
محاسبة	1	300	3,600	3,600	-
اداري/ كاتب/ سجلات طبية	1	300	3,600	-	3,600
مراسل	1	220	2,640	-	2,640
المجموع	33		187,440	21,600	165,840

كما يبين الجدول التالي الوصف الوظيفي العام للوظائف المطلوبة في المشروع.

الجدول 36: الوصف الوظيفي العام للوظائف المطلوبة في المشروع

الوظيفة	وصف الوظيفة
مدير عام	التخطيط والتنظيم والتنسيق والمراقبة لكل ما يتعلق بالإدارة الداخلية للشركة، والمشاركة في تحديد سياسة الشركة وإدارة كل ما له علاقة بالعمل. ومراجعة التقارير التي ترد إلى قسم الإدارة والإشراف على عملية تحليلها ودراسة المشاكل التي تبرز ووضع الحلول لها، والإشراف الفني والإداري على الموظفين ورفع كفاءتهم، ومراعاة تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية.
رئيس قسم التمريض/ المدير الفني	يقوم بإدارة ومتابعة الأعمال المرتبطة بالقسم من الناحية الفنية وتوزيع الأعمال بالأسلوب العلمي ووضع سياسة واضحة للعمل وإعداد وتجهيز الشركة من المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية وغير الطبية وتطوير أساليب العمل والخدمات المقدمة بالإضافة إلى المتابعة والإشراف على البرامج التدريبية التي تجرى بالشركة، والتأكد من الضوابط والأنظمة المطبقة لذلك. وعلى المدير الفني القيام بالواجبات التالية: - الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم - توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة - وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن هذه الخطة الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها والأدوية والعلاجات والمضاعفات أثناء الإقامة والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله - تنظيم السجلات والمفات - التقيد بشروط السلامة العامة

الوظيفة	وصف الوظيفة
	- التقيد بأسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية - توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر - التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري - توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية - الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة أو خدماتها - التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب التشريعات المعمول بها - إعلان لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية في مكان بارز من المؤسسة - إعلان قائمة لحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة
رئيس قسم العلاج الطبيعي/ أخصائي علاج حكومي	يقوم بإدارة ومتابعة الأعمال المرتبطة بالقسم من الناحية الفنية وتوزيع الأعمال بالأسلوب العلمي ووضع سياسة واضحة للعمل وإعداد وتجهيز المركز من المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية وغير الطبية وتطوير أساليب العمل والخدمات المقدمة بالإضافة إلى المتابعة والإشراف على البرامج التدريبية التي تجرى بالمركز، والتأكد من الضوابط والأنظمة المطبقة لذلك. وعلى رئيس القسم القيام بالواجبات التالية: - الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم - توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة - اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى - تنظيم السجلات والمفات وفتح سجل علاجي لكل مريض - التقيد بشروط السلامة العامة - توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر - التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري - توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية - الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المركز أو خدماته - التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب التشريعات المعمول بها - إعلان لائحة أجور معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية في مكان بارز داخل المركز - إعلان قائمة لحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيدين في مكان بارز في المركز
المرضى / الممرضة	يقوم الممرض بأداء المهام التالية: - أداء مهام التمريض اليومية للمرضى في منازلهم وبحسب توجيهات الطبيب وخطة العلاج التي يضعها الطبيب المشرف على الحالة ويمتاعو مباشرة من المدير الفني. - إعداد المريض للإجراءات المقررة والمساعدة في تقييم حالة المريض. - معاونة الطبيب في إجراء الفحوصات وأية إجراءات متعلقة بالعناية المباشرة بالمريض.

الوظيفة	وصف الوظيفة
	- تقديم العناية التمريضية للمريض فيما يتعلق بالمحافظة على صحته ومعاونته على القيام بأبسط المهام اليومية التي يمارسها. - ملاحظة حالة المريض الصحية وإبلاغ أية تغييرات للمدير الفني والطبيب المشرف على الحالة. - القيام بجميع الإجراءات الضرورية لمنع انتشار العدوى ومساعدة المريض على الأكل والاستحمام والعناية الشخصية وأخذ الأدوية بانتظام. - مساعدة المريض وتحضيره لأخذ العينات المخبرية بانتظام وكذلك مساعدته على أخذ المحاليل الوريدية. - توفير المساندة النفسية للمريض وإظهار الاهتمام براحة المريض والمحافظة على خصوصيته خلال كل المراحل.
المحاسب/ الإداري/ كاتب السجلات	يقوم المحاسب بأداء المهام التالية: - المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية للإدارة وذلك بالتنسيق مع المعنيين في الشركة. - متابعة إعداد ومراجعة وتعديل واعتماد النظام والتنظيم الإداري الخاص بالوحدة التنظيمية والذي يشمل على الإجراءات والقواعد والتعليمات والهيكل التنظيمي والوظيفي والمهام والاختصاصات وبطاقات الوصف الوظيفي ولائحة الصلاحيات. - إنشاء الخطط المالية الخاصة بالمركز ومراقبة السياسات والإجراءات الخاصة بالخطط المالية والتأكد من أنها تتوافق مع الأنظمة والقوانين. - إعداد الموازنة التقديرية بما تشمله من الرواتب والبدايات، المصروفات التشغيلية، برامج الصيانة والتشغيل، الحالات المرضية والعلاجية الحالية والجديدة. - متابعة عمليات المقارنة بين الحسابات بالتنسيق مع العمليات. - تقديم كافة خدمات الموارد البشرية مثل التوظيف والتقييم وإعداد خطط الأداء والترقيات وما إلى ذلك، كما يعمل على إعداد سياسات الموارد البشرية وقواعدها وإجراءاتها وبرامجها. - القيام بالإجراءات والسياسات الخاصة بضمان حضور وانصراف الموظفين وصرف مستحقاتهم المالية بموجبها وقيد الإجازات المسحوبة من قبلهم. - إعداد كشوف الرواتب الخاصة بموظفي المركز والتقارير الخاصة بمعلومات الدوام والانضباط في العمل. - الإشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات لجميع الوظائف الشاغرة في المركز من أجل استقطاب الموظفين الذين يحملون الموصفات التي تناسب متطلبات الوظائف. - متابعة استقبال طلبات التوظيف الواردة إلى الشركة و أرشفتها وفرزها واختيار الطلبات التي تلبي احتياجات العمل - متابعة وتحديث سجلات المرضى والمستفيدين من خدمات مركز العلاج الطبيعي وذلك بالتنسيق مع المدير/ الممرض/ أخصائي العلاج الطبيعي المعني

4.4 الاشتراطات الخاصة

يبين الجدول التالي الاشتراطات العامة والخاصة لشركات الرعاية المنزلية التي يجب مراعاتها لتطوير وتنفيذ المشروع.

الجدول 37: الاشتراطات العامة والخاصة لشركة الرعاية الصحية المنزلية

البيان	الشروط
خدمات الرعاية الصحية	تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية أيًا من الخدمات التالية: - المعالجة الطبية - الرعاية التمريضية - المعالجة الحكيمة - العلاج الوظيفي - التغذية - علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي - معالجة النطق والسمع تقدم الخدمات للمستفيد في مكان إقامته بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية
العاملون	يشترط في كلٍ من المدير الفني ورئيس المركز الحكي ما يلي: - أن يكون أردني الجنسية - غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة - أن لا يكون ملتزماً بالخدمة لأي جهة أخرى - أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها - أن لا تقل خبرة المدير الفني العملية في مجال مهنته عن خمس سنوات - أن يكون حاصلاً على تصريح مزاولة أي من المهن الصحية أو الطبية من الوزارة - أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة الشركة - يشترط في مدير المركز حصوله على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في تخصص العلاج الحكي. على المدير الفني / مدير مركز العلاج الحكي التقيد بما يلي: - شروط السلامة العامة

البيان	الشروط
	■ أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجود الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية ■ توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر ■ التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري ■ توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ■ الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة أو خدماتها ■ التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب التشريعات المعمول بها ■ إعلان لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية في مكان بارز من المؤسسة ■ إعلان قائمة لحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة يتولى كل من المدير الفني ومدير مركز العلاج الحكمي المهام التالية: ■ الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم ■ توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة ■ وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن هذه الخطة الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها والأدوية والعلاجات والمضاعفات أثناء الإقامة والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله ■ تنظيم السجلات والمفات على مالك الشركة تبليغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص الشركة.
المبنى	■ أن لا تقل مساحة المبنى المخصص لقسم الرعاية الصحية المنزلية عن 80 م² ■ أن لا تقل مساحة المبنى المخصص لقسم العلاج الحكمي عن 100 م² ■ ينبغي توافر ما يلي داخل المركز: - صالة إنتظار - غرف للمعالجة - مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الاشخاص ذوي الاعاقة - الاجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة - وجود مصعد مناسب في حال لم يقع المركز في الطابق الأرضي ■ في حال رغبت الشركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية إضافة إلى العلاج الحكمي داخل مركز متخصص، فيجب فصل مدخل كل قسم عن الآخر ■ لا يجوز تقديم الرعاية الصحية داخل مقر الشركة / القسم ■ لا يجوز بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويسمح بتوفيرها

4.5 التراخيص المطلوبة

يبين الجدول التالي التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة لتنفيذ المشروع.

الجدول 38: التراخيص المطلوبة للمشروع

البيان	التحليل
تسجيل الشركة	- وزارة الصناعة والتجارة - وزارة الصحة
التشغيل	- وزارة الصحة - الضمان الاجتماعي - ضريبة الدخل والمبيعات - بلدية الزرقاء

شروط ترخيص المؤسسة:²

يشترط لترخيص الشركة توافر ما يلي:

- شروط السلامة العامة والشروط الصحية اللازمة كإضاءة وتهوية
- مدير فني / مدير مركز
- وسائل الاتصالات اللازمة
- عدد من مقدمي الخدمة ومن الموظفين الإداريين وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية

تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:

- سجلات مقدمي الخدمة
- سجلات العاملين في المؤسسة
- الملفات الطبية للمستفيدين

يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية برئاسة مدير المديرية المعنية في الوزارة،

وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

- النظر في طلب ترخيص المؤسسة
- الكشف عن المؤسسة المطلوب ترخيصها من عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة

² نظام رقم (84) لسنة 2016: نظام ترخيص مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية

- دراسة الشكاوي المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسة ومتابعة تجديد ترخيصها
- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها
- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها

4.6 الجدول الزمني للمشروع

يبين الشكل التالي المدة الزمنية لتنفيذ المشروع والتي تبلغ 6 أشهر، وذلك كما يلي:

الأشهر						المرحلة
6	5	4	3	2	1	
						الدراسات
						الموافقات وتسجيل الشركة
						التجهيز والتأثيث
						التوظيف والتشغيل والإفتتاح
6 أشهر						إجمالي المدة

5. الدراسة المالية للمشروع

5.1 الافتراضات المالية

يبين الجدول التالي الفرضيات المتعلقة المالية المتوقعة للمشروع.

الجدول 39: الفرضيات المالية المتوقعة للمشروع

البيان	الافتراض
معدل التضخم في الأسعار	3%
التمويل	100% من الاستثمار هو رأس المال
رأس المال العامل	6 شهور من التكاليف
مصاريف ما قبل التشغيل	3% من الاستثمار
معدل الضريبة	20%
تكاليف التعاقد مع أطباء عظام وعلاج طبيعي للإشراف على الحالات داخل المركز	20% من الإيرادات
كلفة المستلزمات الطبية	30% من الإيرادات
مياه ومحروقات وكهرباء	3% من الإيرادات
الإهلاكات السنوية	27 ألف دينار سنوياً
الصيانة	2000 دينار سنوياً
الإيجارات	8 آلاف دينار في السنة الأولى وزيادة بمقدار 3%
تكاليف تشغيلية أخرى	2% من الإيرادات
مصاريف الموظفين من الضمان والتأمين الصحي	25% من الرواتب
الزيادة السنوية في الرواتب	3%
حوافز الموظفين	1% من الإيرادات
معدل إهلاكات الأصول	10% - 20% من قيمة الأصل
الذمم المدينة	شهر من التكاليف
المخزون	3% من الإيرادات

5.2 تكاليف الاستثمار

تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 321 ألف دينار موزعة على الأصول الثابتة بقيمة 178 ألف دينار، ورأس المال العامل ومصاريف ما قبل التشغيل بحوالي 143 ألف دينار، ويبين الجدول التالي تكاليف الاستثمار للمشروع.

الجدول 40: تكاليف الاستثمار للمشروع

البند	القيمة (ألف دينار)
الأصول الثابتة	178
مصاريف ما قبل التشغيل	9
رأس المال العامل	134
المجموع	321

5.3 التمويل

سيتم تمويل المشروع كاملاً عن طريق مساهمات الشركاء في الشركة بنسبة 100% والتي تقدر بحوالي 321 ألف دينار حيث أنه لن تكون هناك أي حاجة للقروض، ويبين الجدول التالي التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

الجدول 41: تمويل المشروع

البند	القيمة (ألف دينار)	%
رأس المال	321	100%
قروض	0	0%
المجموع	321	100%

5.4 الإيرادات

يبين الجدول التالي الإيرادات الكلية للمشروع، حيث يلاحظ بأن الإيرادات تبلغ في السنة الأولى حوالي 252.3 ألف دينار وتزداد لتصل 518.7 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 42: إيرادات المشروع

البيان	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5	السنة 6	السنة 7	السنة 8	السنة 9	السنة 10
الإيرادات - التمريض المنزلي										
عدد أيام العمل سنوياً	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
متابعة الحالات المنزلية البسيطة شهرياً مثل السكري والضغط والجروح والحروق... الخ (عن طريق الجمعيات الخيرية المحلية والمنظمات الدولية) / الزيارة لمدة ساعة وبمعدل 60 زيارة سنوياً										
عدد الحالات السنوية	255	310	310	310	310	310	310	310	310	310
متوسط الأتعاب السنوية	450	464	477	492	506	522	537	553	570	587
إجمالي الإيراد من الحالات البسيطة	114,750	143,685	147,996	152,435	157,008	161,719	166,570	171,567	176,714	182,016
متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة مثل كبار السن والعظام والكسور والعجز الجزئي ولكن لفترة محدودة (مدة الزيارة لا تقل عن 8 ساعات في الغالب)										
عدد الحالات السنوية	6	9	12	12	12	12	12	12	12	12
متوسط عدد الزيارات في السنة	104	104	104	104	156	156	156	156	156	156
متوسط الأتعاب للزيارة الواحدة	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33
إجمالي الإيرادات من متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة ولكن بعدد زيارات أسبوعية محدد	15,600	24,102	33,100	34,093	52,674	54,254	55,882	57,558	59,285	61,063
متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة ولكن بشكل جزئي (مدة الزيارة 8 - 12 ساعة في الغالب)										
عدد الحالات السنوية	9	11	13	13	13	13	13	13	13	13
متوسط الأتعاب الشهرية	650	670	690	710	732	754	776	799	823	848
الفترة الزمنية (شهر)	3	3	3	4	4	5	5	6	6	6

السنة 10	السنة 9	السنة 8	السنة 7	السنة 6	السنة 5	السنة 4	السنة 3	السنة 2	السنة 1	البيان
66,152	64,225	62,355	50,449	48,979	38,042	36,934	26,894	22,094	17,550	إجمالي الإيراد من متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة ولكن بشكل جزئي
متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة على مدار الساعة مثل الغيبوبة والعجز الكلي (ورديتين مدة كل وردية 12 ساعة)										
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	عدد الحالات السنوية
1,566	1,520	1,476	1,433	1,391	1,351	1,311	1,273	1,236	1,200	متوسط الأتعاب الشهرية
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	الفترة الزمنية (شهر)
75,155	72,966	70,841	68,777	66,774	64,829	62,941	61,108	59,328	57,600	إجمالي الإيرادات من متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية مستمرة على مدار الساعة مثل الغيبوبة والعجز الكلي (ورديتين مدة كل وردية 12 ساعة)
384,386	373,190	362,321	341,678	331,726	312,554	286,404	269,097	249,209	205,500	إجمالي الإيرادات من التمريض المنزلي
الإيرادات - العلاج الحكلي										
السنة 10	السنة 9	السنة 8	السنة 7	السنة 6	السنة 5	السنة 4	السنة 3	السنة 2	السنة 1	البيان
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	عدد أيام العمل سنوياً
4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,200	3,300	2,400	2,000	1,800	عدد الحالات/الجلسات السنوية داخل المركز
14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	متوسط أتعاب الجلسة/ الحالة

السنة 10	السنة 9	السنة 8	السنة 7	السنة 6	السنة 5	السنة 4	السنة 3	السنة 2	السنة 1	البيان
64,586	62,705	60,879	59,106	57,384	51,999	39,666	28,008	22,660	19,800	الإيرادات من معالجة الحالات داخل المركز
1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,400	1,100	800	600	400	عدد الحالات/الجلسات السنوية خارج المركز
21	20	20	19	19	18	17	17	16	16	متوسط أتعاب الجلسة/ الحالة خارج المركز
31,315	30,402	29,517	28,657	27,823	25,211	19,232	13,580	9,888	6,400	الإيرادات من معالجة الحالات خارج المركز
95,901	93,108	90,396	87,763	85,207	77,210	58,898	41,587	32,548	26,200	إجمالي الإيرادات من العلاج الطبيعى
الإيرادات										
384,386	373,190	362,321	341,678	331,726	312,554	286,404	269,097	249,209	205,500	إجمالي الإيرادات من التمريض المنزلي
95,901	93,108	90,396	87,763	85,207	77,210	58,898	41,587	32,548	26,200	إجمالي الإيرادات من العلاج الطبيعى
38,439	37,319	36,232	34,168	33,173	31,255	28,640	26,910	24,921	20,550	إيرادات أخرى (من خدمة المستلزمات الطبية للمريض المنزلي)
518.73	503.62	488.95	463.61	450.11	421.02	373.94	337.59	306.68	252.25	إجمالي الإيرادات (ألف دينار)

5.5 التكاليف المتوقعة

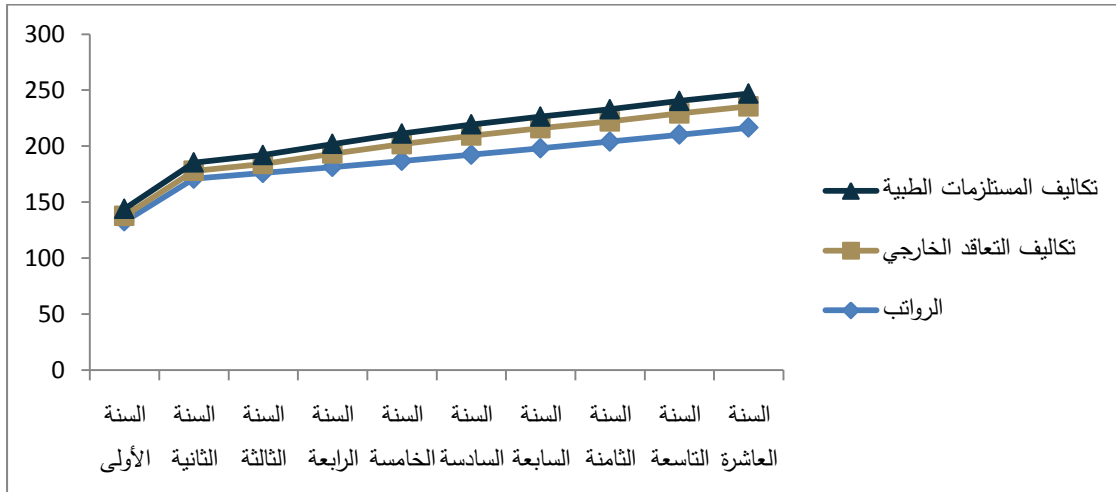
التكاليف التشغيلية

يبين الجدول التالي التكاليف التشغيلية للمشروع خلال العشر سنوات القادمة، حيث تبلغ كلفة المستلزمات الطبية في السنة الأولى 6.2 ألف دينار وتزداد إلى 11.5 ألف دينار في السنة العاشرة، كما تبلغ كلفة الرواتب 133 ألف دينار في السنة الأولى وتزداد إلى 216 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 43: التكاليف التشغيلية للمشروع

التكاليف التشغيلية (ألف دينار)										
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
216.4	210.1	204.0	198.0	192.3	186.7	181.2	175.9	170.8	132.7	الرواتب
54	53	51	50	48	47	45	44	43	33	مصاريف موظفين أخرى
19	19	18	18	17	15	12	8	7	5	تكاليف التعاقد الخارجي
11.5	11.2	10.9	10.3	10.0	9.4	8.6	8.1	7.5	6.2	تكاليف المستلزمات الطبية
9.9	9.6	9.3	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0	7.8	7.6	مياه ومحروقات وكهرباء
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	إهلاكات
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	صيانة
10.4	10.1	9.8	9.3	9.0	8.4	7.5	6.8	6.1	5.0	أخرى
10	10	9	9	9	8	8	8	8	8	الإيجارات
360	351	341	332	323	312	300	288	278	226	المجموع

الشكل 5: التكاليف التشغيلية للمشروع



التكاليف الإدارية

يبين الجدول التالي التكاليف الإدارية المتوقعة للمشروع، حيث تبلغ رواتب الموظفين 15 ألف دينار في السنة الأولى وتزداد إلى 20 ألف دينار في السنة العاشرة، وتبلغ المصاريف التسويقية حوالي 5 آلاف دينار في السنة الأولى وتزداد إلى حوالي 6.6 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 44: المصاريف الإدارية والعمومية

المصاريف الإدارية والعمومية (ألف دينار)										البند
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة	
15.1	15.6	16.0	16.5	17.0	17.5	18.1	18.6	19.2	19.7	الرواتب
3.8	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	مصاريف موظفين أخرى
2.5	3.1	3.4	3.7	4.2	4.5	4.6	4.9	5.0	5.2	حوافز الموظفين
2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	قرطاسية ومصاريف
2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	اتعاب مهنية
5.0	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	مصاريف تسويقية
2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	مصاريف أخرى
9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
42.3	34.5	35.8	37.2	38.8	40.2	41.5	43.0	44.4	45.9	المجموع

5.6 القوائم المالية المتوقعة

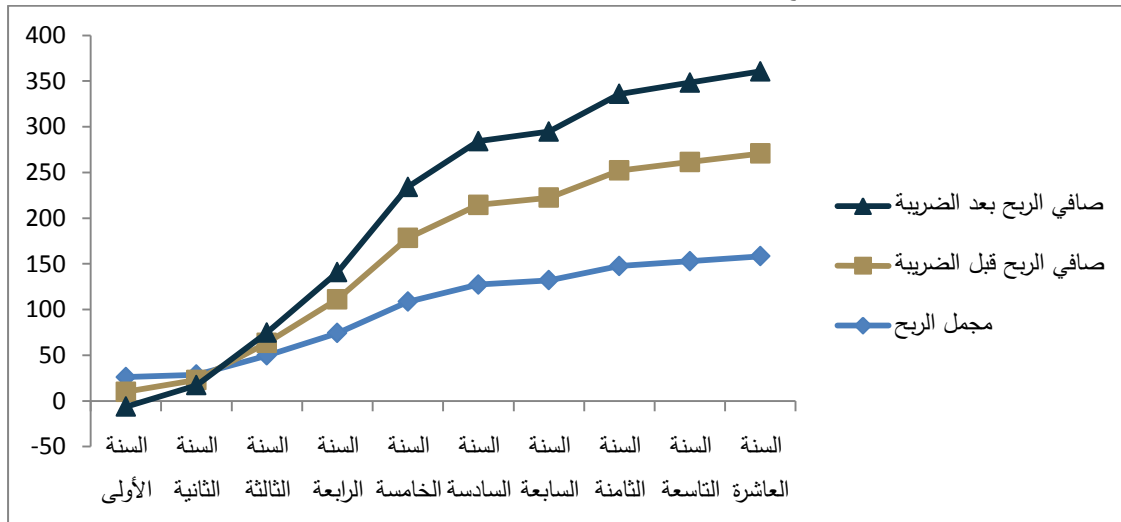
قائمة الدخل

يبين الجدول التالي قائمة الدخل المتوقعة للمشروع، حيث يلاحظ أن مجمل الربح سيزداد من 26 ألف دينار في السنة الأولى إلى 158 ألف دينار في السنة العاشرة، كما سيزداد صافي الربح قبل الضريبة من 14 ألف دينار في السنة الثالثة إلى 112 ألف دينار في السنة العاشرة، وسيزداد صافي الربح بعد الضريبة من 11 ألف دينار في السنة الثالثة إلى 90 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 45: قائمة الدخل المتوقعة للمشروع

قائمة الدخل (ألف دينار)										
البند	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
الإيرادات	252.3	306.7	337.6	373.9	421.0	450.1	463.6	488.9	503.6	518.7
التكاليف التشغيلية	226.1	278.0	287.9	299.7	312.5	322.8	331.6	341.3	350.7	360.4
مجموع الربح	26.1	28.7	49.7	74.2	108.6	127.3	132.0	147.6	152.9	158.3
مصاريف إدارية	42.3	34.5	35.8	37.2	38.8	40.2	41.5	43.0	44.4	45.9
صافي الربح	(16.2)	(5.8)	13.9	37.0	69.7	87.1	90.4	104.6	108.5	112.4
مصاريف بنكية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صافي الربح قبل الضريبة	(16.2)	(5.8)	13.9	37.0	69.7	87.1	90.4	104.6	108.5	112.4
الضريبة	-	-	2.8	7.4	13.9	17.4	18.1	20.9	21.7	22.5
صافي الربح بعد الضريبة	(16.2)	(5.8)	11.1	29.6	55.8	69.7	72.3	83.7	86.8	89.9

الشكل 6: قائمة الدخل المتوقعة للمشروع



قائمة المركز المالي

يبين الجدول التالي الميزانية العمومية المتوقعة للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ أن مجموع الأصول سيزداد من 321 ألف دينار في سنة التأسيس ليصل إلى حوالي 509 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 46: المركز المالي المتوقع للمشروع

قائمة المركز المالي (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	سنة التأسيس	البيان
الأصول											
445	391	338	287	239	192	247	213	185	162	134	النقدية
43	42	41	39	38	35	31	28	26	21	-	الذمم
16	15	15	14	14	13	11	10	9	8	-	المخزون
5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	-	موجودات أخرى
509	453	399	345	294	244	293	255	223	193	134	مجموع الأصول المتداولة
282	282	282	282	282	282	187	187	187	187	187	الأصول الثابتة
282	255	227	200	173	146	118	91	64	37	-	مجموع الاهلاك
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف ما قبل التشغيل
-	27	55	82	109	136	69	96	123	150	187	صافي الأصول
509	481	453	426	403	381	362	351	346	343	321	مجموع الأصول
الالتزامات وحقوق الملكية											
61	59	57	56	54	52	50	48	47	38	-	مصاريف مستحقة ودمم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
61	59	57	56	54	52	50	48	47	38		مجموع الالتزامات
321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	مساهمات الشركاء
128	101	75	50	28	7	(10)	(19)	(22)	(16)	-	أرباح مدورة
449	422	396	371	349	328	311	302	299	305	321	مجموع حقوق الملكية
509	481	453	426	403	381	362	351	346	343	321	مجموع الالتزامات لحقوق الملكية

قائمة التدفق النقدي

يبين الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ أن التدفق النقدي من التشغيل سيزداد من 27 ألف دينار في السنة الأولى إلى 117 ألف دينار في السنة العاشرة، أما النقد آخر المدة فسيزداد من 134 ألف دينار في سنة التأسيس إلى 445 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 47: قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع

قائمة التدفقات النقدية (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	سنة التأسيس	البيان
الأنشطة التشغيلية											
90	87	84	72	70	56	30	11	(6)	(16)	-	صافي الربح
27	27	27	27	27	27	27	27	27	37	-	الإهلاكات
(0)	(0)	(2)	(0)	(2)	(4)	(2)	(2)	2	7	-	التغير في رأس المال العامل
117	114	109	99	95	79	54	36	23	27	-	التدفق النقدي من التشغيل
الأنشطة الاستثمارية											
-	-	-	-	-	(95)	-	-	-	-	(187)	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	(95)	-	-	-	-	(187)	التدفق النقدي من الاستثمار
الأنشطة التمويلية											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	رأس المال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القرض
(63)	(61)	(59)	(51)	(49)	(39)	(21)	(8)	-	-	-	توزيع الأرباح
(63)	(61)	(59)	(51)	(49)	(39)	(21)	(8)	-	-	321	التدفق النقدي من التمويل
54	53	51	49	46	(55)	34	28	23	27	134	صافي التدفق النقدي
391	338	287	239	192	247	213	185	162	134	0	النقد أول المدة
445	391	338	287	239	192	247	213	185	162	134	النقد آخر المدة

5.7 التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي

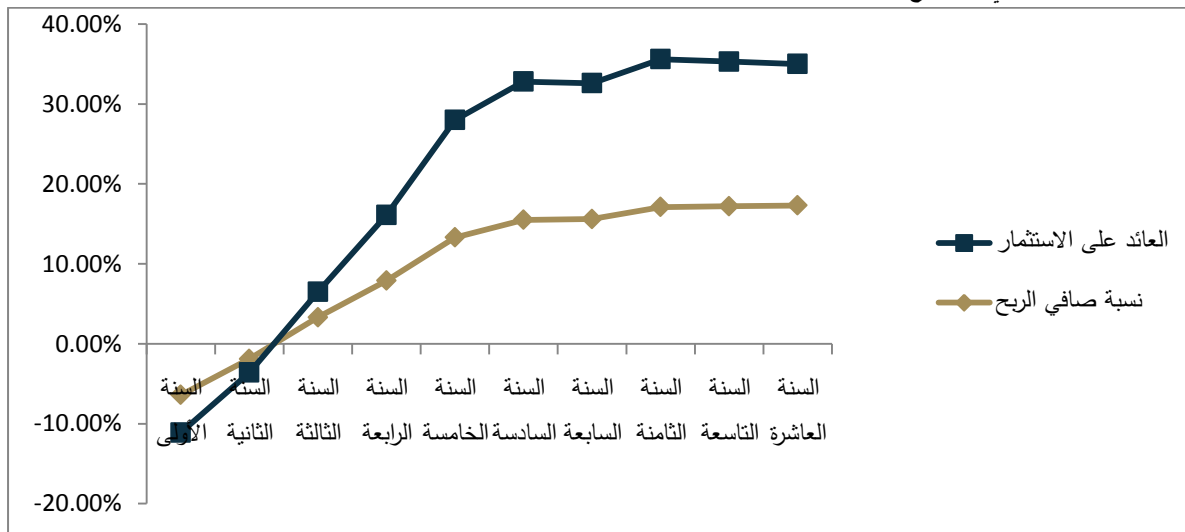
التحليل المالي

يبين الجدول التالي التحليل المالي للمشروع حيث يلاحظ أن نسبة صافي الربح ستزداد من 3.3% في السنة الثالثة إلى 17.3% في السنة العاشرة، كما أن العائد على الاستثمار سيزداد من 3.2% في السنة الثالثة إلى 17.7% في السنة العاشرة.

الجدول 48: التحليل المالي للمشروع

التحليل المالي (ألف دينار)										البند
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	
509	481	453	426	403	381	362	351	346	343	الأصول
519	504	489	464	450	421	374	338	307	252	الإيرادات
90	87	84	72	70	56	30	11	(6)	(16)	الأرباح
321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	رأس المال
17.3%	17.2%	17.1%	15.6%	15.5%	13.3%	7.9%	3.3%	-1.9%	-6.4%	نسبة صافي الربح
17.7%	18.1%	18.5%	17.0%	17.3%	14.7%	8.2%	3.2%	-1.7%	-4.7%	العائد على الاستثمار
28.0%	27.0%	26.1%	22.5%	21.7%	17.4%	9.2%	3.5%	-1.8%	-5.0%	العائد على رأس المال
17.3%	17.2%	17.1%	15.6%	15.5%	13.3%	7.9%	3.3%	-1.9%	-6.4%	معدل العائد على الإيرادات
1.02	1.05	1.08	1.09	1.12	1.11	1.03	0.96	0.89	0.74	معدل دوران الأصول (مرة)

الشكل 7: التحليل المالي للمشروع



التحليل الاقتصادي

- يبين الجدول التالي التحليل الاقتصادي للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ ما يلي:
- بلغ معدل العائد الداخلي 19.7% والذي تجاوز 4 أضعاف معدل العائد على الأصول مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً
 - بلغت القيمة الحالية للمشروع حوالي 478 ألف دينار وقد ازدادت عن الاستثمار بقيمة 157 ألف دينار مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً
 - بلغ مؤشر الربحية للمشروع 1.49 مرة مما يعني أن قيمة المشروع المتوقعة ستكون ضعف ونصف قيمة الاستثمار ولذلك يعتبر المشروع مجدي اقتصادياً
 - بلغت فترة استرداد المشروع حوالي 6 سنوات

الجدول 49: التحليل الاقتصادي للمشروع

التحليل الاقتصادي (ألف دينار)											البيان
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	التأسي س	
117	114	109	99	95	79	54	36	23	27	(321)	صافي التدفق النقدي من العمليات والاستثمار
449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القيمة المتبقية
566	114	109	99	95	79	54	36	23	27	(321)	التدفق النقدي
										19.7%	العائد الداخلي
										478	القيمة الحالية
										157	صافي القيمة الحالية
										1.49	مؤشر الربحية (مرة)
										6.00	فترة الاسترداد (سنة)

التحليل الاجتماعي

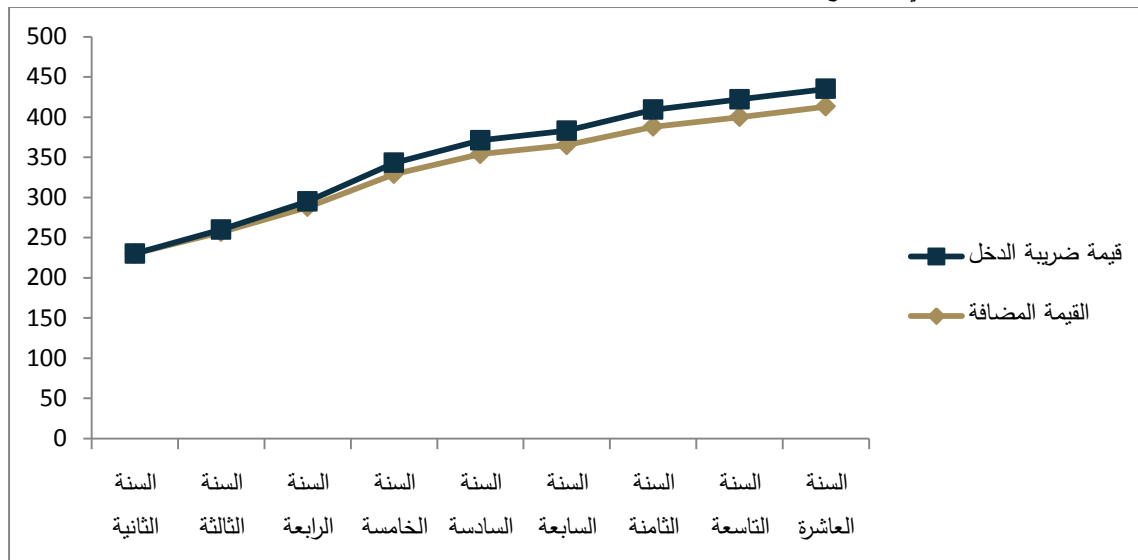
يبين الجدول التالي التحليل الاجتماعي للمشروع، حيث يلاحظ من التحليل أن عدد الموظفين المطلوب في المشروع سيزداد من 33 موظف في السنة الأولى ليصل إلى 51 موظف في السنة العاشرة، حيث أن كافة هؤلاء الموظفين من الجنسية الأردنية.

كما أن القيمة المضافة للمشروع ستزداد من 171 ألف دينار في السنة الأولى إلى 413 ألف دينار في السنة العاشرة، كما ستزداد ضريبة الدخل من 3 آلاف دينار في السنة الثالثة لتصل إلى 22 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 50: التحليل الاجتماعي للمشروع

التحليل الاجتماعي										البيان
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	
51	49	46	44	42	40	38	36	35	33	عدد الموظفين
51	49	46	44	42	40	38	36	35	33	عدد الموظفين الأردنيين المتوقع
413	400	388	365	354	329	288	257	230	171	القيمة المضافة - ألف دينار
22	22	21	18	17	14	7	3	-	-	قيمة ضريبة الدخل - ألف دينار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قيمة ضريبة المبيعات - ألف دينار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قيمة التصدير / احلال مستوردات

الشكل 8: التحليل الاجتماعي للمشروع



6. دراسة المخاطر وتحليل الحساسية

6.1 دراسة المخاطر

يبين الجدول التالي مصفوفة المخاطر التي تواجه المشروع وأسس تجنب المخاطر المتوقعة.

الجدول 51: مصفوفة المخاطر للمشروع

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
المخاطر المالية	■ مخاطر الائتمان تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم التجارية والأخرى.	■ تعتبر المخاطر المالية التي يمكن ان تواجه الشركة قليلة وذلك لان طريقة الدفع نقدياً
	■ مخاطر السيولة إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن إدارة الشركة للسيولة تكمن في التأكد قدر الإمكان من أن الشركة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.	■ لا يوجد مخاطر تقلب سعر العملات لأن خدمات الشركة سوف تقدم محلياً
	■ مخاطر تقلب أسعار العملات تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية.	■ لا يوجد مخاطر للتضخم لأن تسعير الشركة يقوم على أساس دوري
	■ مخاطر التضخم هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.	

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
مخاطر الأعمال (مخاطر القطاع)	■ المخاطر الإستراتيجية هي المخاطر الناجمة عن إتخاذ إدارة الشركة قرارات خاطئة أو تنفيذ القرارات بشكل خاطئ أو عدم إتخاذ القرار في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يؤدي الى إلحاق خسائر أو ضياع فرص بديلة. ■ المخاطر القانونية والتنظيمية تتجلى هذه المخاطر نتيجة عدم الإلتزام بالقوانين والإرشادات والتعليمات المنظمة للعمل، وتنشأ المخاطر القانونية عن عدم التزام الشركة بالقوانين المنظمة للعمل في الدولة التي تعمل بها الشركة، في حين تنشأ المخاطر التنظيمية عن مخالفة الشركة القوانين والمعايير الصادرة عن السلطات الرقابية. ■ مخاطر السمعة تنتج مخاطر السمعة عن الآراء العامة السلبية المؤثرة والتي ينتج عنها خسائر كبيرة للملاء أو الأموال، حيث تتضمن الأفعال التي تمارس من قبل إدارة الشركة أو موظفيه والتي تعكس صورة سلبية عن الشركة وأدائها وعلاقاتها مع عملائها والجهات الأخرى، كما أنها تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن الشركة ونشاطها. ■ مخاطر المنافسة تنتج مخاطر المنافسة من السوق المحلي والخارجي والتي تؤثر على تقليل المبيعات وتخفيض الأرباح.	■ تعتبر المخاطر قليلة قبل تأسيس الشركة وذلك للحصول على موافقة الجهات الرسمية ■ مخاطر السمعة مرتفعة جداً بسبب تعامل الشركة مع موضوعات حساسة جداً مثل العلاج ■ مخاطر السوق في الاجل القصير سوف تكون قليلة بسبب عدم وجود شركات منافسة من القطاع الخاص
المخاطر التشغيلية	وهي مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم نجاح أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، والأنظمة والأحداث الخارجية وتشمل: ■ مخاطر تقنية المعلومات الخسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل الأنظمة بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، أو عدم توفر الأنظمة، وأي عطل أو خلل في الأنظمة، وتشمل: إنهاء أنظمة الحاسوب، الأعطال في أنظمة الاتصالات، أخطاء	■ تعتبر المخاطر التشغيلية متدنية جداً حيث ستتعاقد الشركة مع جهات فنية متخصصة لتطوير أنظمة المعلومات المطلوبة لإدارة العمليات ■ سوف يتم دفع رواتب منافسة في السوق

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر/ التجنب
	البرمجة، فيروسات الحاسوب، الفائدة المفقودة بسبب العطل. ■ مخاطر الموارد البشرية الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق بالموظفين (بقصد أو بدون قصد)، كما تشمل الأفعال التي يكون الهدف منها الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة من قبل المسؤولين أو الموظفين، وكذلك الخسائر الناشئة عن العلاقة مع العملاء، المساهمين، الجهات الرقابية وأي طرف ثالث.	■ سوف يتم وضع خطة أمن معلومات للحفاظ على معلومات الشركة
مخاطر الدولة	تشمل المخاطر السياسية تدخل السياسيين، والاضطرابات المدنية، والحروب، والسياسات المالية والنقدية وارتفاع مستوى الديون.	■ تعتبر مخاطر متدنية بسبب الأمن والاستقرار السياسي، حيث تشير التقارير الدولية إلى تدني مخاطر الدولة في الأجل المتوسط والأجل الطويل

6.2 تحليل الحساسية

أولاً: زيادة الاستثمار بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند زيادة الاستثمار بمعدل 10%.

الجدول 52: زيادة الاستثمار 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغيير
معدل العائد الداخلي	19.7%	18.3%	1.4%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	477.7	487.1	-9.5
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	156.6	133.9	22.6
مؤشر الربحية (مرة)	1.5	1.4	0.1
فترة الاسترداد (سنة)	6.0	6.4	-0.4
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	9.9%	9.9%	0.0%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	10.8%	10.1%	0.7%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	14.9%	13.5%	1.4%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	9.9%	9.9%	0.0%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	1.0	0.9	0.1
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	319.5	319.5	0.0
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	12.5	12.5	0.0
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0

ويشير التحليل السابق إلى جدوى الاستثمار في المشروع في ظل ارتفاع كلفة الاستثمار الكلي للمشروع بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 18.3% وهو مرتفع لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 6.4 سنوات وتعتبر فترة معقولة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 13.5% وهو مناسب لأغراض الاستثمار

ثانياً: تخفيض الإيرادات بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند تخفيض الإيرادات بنسبة 10%.

الجدول 53: تخفيض الإيرادات 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغيير
معدل العائد الداخلي	19.7%	10.3%	9.4%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	477.7	264.4	213.2
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	156.6	-56.6	213.2
مؤشر الربحية (مرة)	1.5	0.8	0.7
فترة الاسترداد (سنة)	6.0	8.7	-2.7
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	9.9%	1.7%	8.2%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	10.8%	3.8%	7.0%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	14.9%	4.2%	10.6%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	9.9%	1.7%	8.2%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	1.0	1.2	-0.2
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	319.5	278.3	41.2
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	12.5	5.4	7.1
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0

ويشير التحليل السابق إلى انخفاض درجة الحساسية في حالة تخفيض الإيرادات أو الطلب بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 10.3% وهو جيد لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 8.7 سنة وتعتبر فترة جيدة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 4.2% وهو ضعيف لأغراض الاستثمار

ثالثاً: زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%.

الجدول 54: زيادة تكاليف التشغيل 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغيير
معدل العائد الداخلي	19.7%	12.3%	7.4%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	477.7	306.6	171.1
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	156.6	-14.5	171.1
مؤشر الربحية (مرة)	1.5	1.0	0.5
فترة الاسترداد (سنة)	6.0	8.0	-2.0
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	9.9%	3.4%	6.5%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	10.8%	5.8%	5.0%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	14.9%	6.8%	8.1%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	9.9%	3.4%	6.5%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	1.0	1.2	-0.2
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	319.5	288.3	31.1
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	12.5	7.3	5.2
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0

ويشير التحليل السابق إلى جدوى المشروع في ظل زيادة تكاليف التشغيل للمشروع بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 12.3% وهو مرتفع لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 8 سنة وتعتبر فترة معقولة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 6.8% وهو جيد لأغراض الاستثمار